AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

SERIE AEE · PERFIL V3

REPASO FINAL

OTORRINOLARINGOLOGÍA

ORL

20 temas · 1 página cada uno · **7** días de plan de repaso

Índice

Cómo usarlo. Un tema por página: lee «Lo que te preguntan», recorre el algoritmo y termina en las trampas y la regla de oro. Después haz las preguntas del Libro Gordo que indica el pie.

★★★ alta · ★★☆ media · ★☆☆ baja — según cuántas preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) hay en los códigos del tema.
Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento.

01 Patología del Oído Externo y Medio

★★☆ 14.1. Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos 3
★★★ 14.2. Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y Colesteatomatosa GES 4
★★★ 14.3. Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos 5
★★★ 14.4. Complicaciones de Otitis: Mastoiditis Aguda y Tromboflebitis 6

02 Audiología & Trastornos del Equilibrio

★★☆ 14.5. Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber) GES 7
★★☆ 14.6. Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia GES 8
★★★ 14.7. Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière 9
★☆☆ 14.8. Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Síndrome de Ramsay Hunt 10

03 Rinología & Senos Paranasales

★★★ 14.9. Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales 11
★★★ 14.10. Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias 12
★☆☆ 14.11. Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos 13
★★★ 14.12. Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal 14

04 Faringe, Laringe & Vía Aérea Superior

★★★ 14.13. Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina 15
★★☆ 14.14. Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo 16
★☆☆ 14.15. Hipertrofia Adenotonsilar y SAHOS Infantil: Indicaciones Quirúrgicas 17
★★☆ 14.16. Disfonía Crónica y Patología Benigna de Cuerdas Vocales: Nódulos, Pólipos y Edema de Reinke 18
★★☆ 14.17. Croup / Laringitis Obstructiva vs Epiglotitis Aguda: Escala de Taussig y Manejo de Emergencia 19

05 Cuerpos Extraños, Glándulas Salivales & Oncología Cervical

★☆☆ 14.18. Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea 20
★★☆ 14.19. Patología de Glándulas Salivales: Sialolitiasis, Parotiditis y Adenoma Pleomorfo 21
★★★ 14.20. Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical GES 22

Números que tienes que saber 23
Fármacos de primera línea 25
GES de la especialidad 26
Plan de repaso de 7 días 27
Índice por prioridad ★ 28

BLOQUE 01 · PATOLOGÍA DEL OÍDO EXTERNO Y MEDIO

14.1 Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
3 preguntas reales 2013–2025

6.03.1.020 Otitis media aguda — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Otitis media · Otitis media recurrente

LO QUE TE PREGUNTAN

- El abombamiento de la membrana timpánica es el signo otoscópico cardinal más específico para el diagnóstico de OMA supurada.
- El tratamiento antimicrobiano de primera línea es la Amoxicilina oral a **80-90 mg/kg**/día dividida cada **12 horas**.
- Si no existe mejoría clínica tras **48 a 72 horas** de amoxicilina, la conducta mandataria es cambiar a Amoxicilina + Ácido Clavulánico (**80-90 mg/kg**/día).
- La presencia de otorrea espontánea calma transitoriamente la otalgia debido a la descompresión mecánica del tímpano.
- La OMA Recurrente se define por **≥ 3 episodios** en **6 meses** o **≥ 4 en** 1 año; requiere evaluación por ORL para inserción de tubos de ventilación.
- En niños menores de **6 meses**, toda sospecha de OMA debe tratarse obligatoriamente con antibióticos sin período de observación.



TÍMPANO NORMAL DERECHO
Bates, Guía de exploración física, Tabla 7-20

ALGORITMO · ALGORITMO DE ENFRENTAMIENTO: OTITIS MEDIA AGUDA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

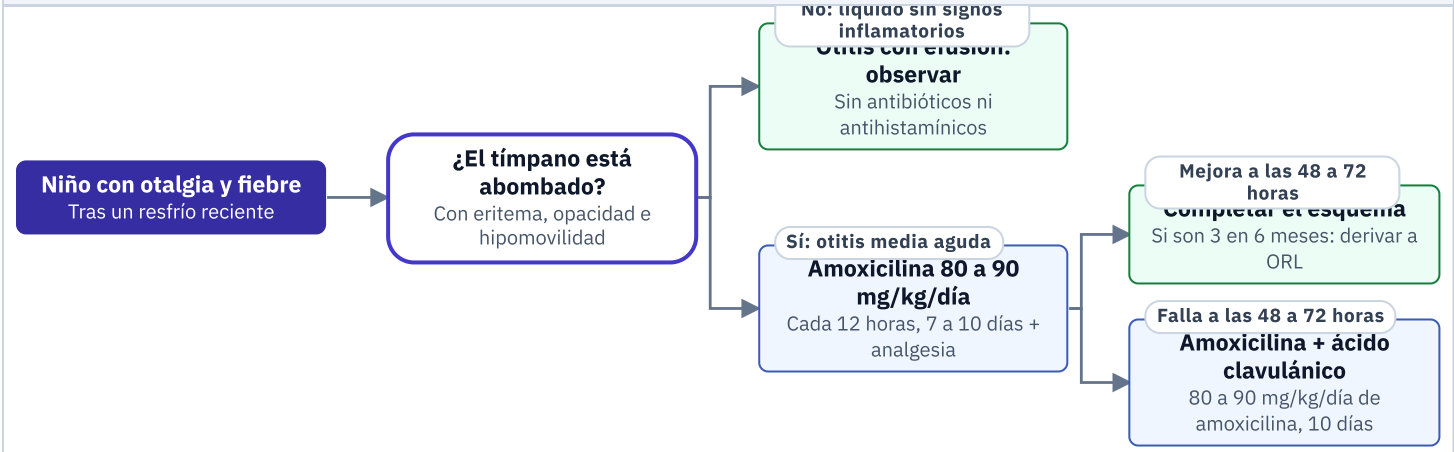


TABLA 14.1 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL OTOSCÓPICO Y MANEJO CLÍNICO EN PATOLOGÍA DE OÍDO MEDIO

ENTIDAD CLÍNICA	SIGNOS OTOSCÓPICOS CARDINALES	SINTOMATOLOGÍA PREDOMINANTE	CONDUCTA TERAPÉUTICA OFICIAL
Otitis Media Aguda (OMA)	Abombamiento timpánico marcado, eritema intenso, opacidad y otorrea aguda si hay perforación	Otalgia lancinante aguda, fiebre, hipoacusia conductiva transitoria	Amoxicilina 80-90 mg/kg/día oral x 7-10 días + analgesia con Paracetamol / Ibuprofeno
Otitis Media con Efusión (OME)	Membrana timpánica retraída, color ámbar/amarillento, nivel hidroaéreo o burbujas visibles	Hipoacusia de conducción indolora, sin fiebre ni eritema agudo	Observación clínica estricta x 3 meses · Prohibidos antibióticos y antihistamínicos
Miringitis Bulosa	Bulás hemorrágicas o serosas en la superficie externa del tímpano	Otalgia súbita e hiperaguda desgarradora, sangrado escaso	Analgesia potente + Macrólido oral (asociado a Mycoplasma pneumoniae y virus)
Otitis Externa Difusa	Edema y eritema circunferencial del CAE con detritos; tímpano indemne	Signo del trago (+), dolor extremo a la tracción del pabellón, prurito	Aseo cuidadoso del CAE + gotas óticas de Ciprofloxacino/Corticoides tópicos

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ENTIDAD	LO QUE VES EN LA OTOSCOPÍA	CONDUCTA
Falla a las 48 a 72 horas	Persisten fiebre, dolor y abombamiento	Cambiar a amoxicilina + clavulánico

REGLA DE ORO **Tímpano abombado = OMA** — El eritema aislado no basta

PRACTICA **Libro Gordo Otorrinolaringología**, preguntas **4–12** (págs. 10–11) · solucionario págs. 25–26.

Clase 14.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · PATOLOGÍA DEL OÍDO EXTERNO Y MEDIO

14.2 Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y Colesteatomatosa

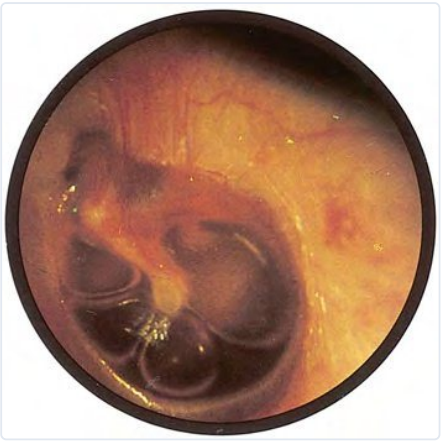
★★★ PRIORIDAD ALTA
6 preguntas reales 2013–2025

6.03.1.021 Otitis media con efusión — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Otitis media crónica y complicaciones · TAC de oídos sin medio de contraste

LO QUE TE PREGUNTAN

- La OME es la causa más común de hipoacusia conductiva en preescolares y se maneja con conducta expectante durante **3 meses**.
- En OME no deben indicarse antibióticos, antihistamínicos ni corticoides de rutina.
- La OMC simple se caracteriza por perforación timpánica central que respeta el annulus, con otorrea no fétida.
- El colesteatoma presenta perforación marginal en la pars flácida con escamas nacaradas blanquecinas y otorrea intensamente fétida.
- El colesteatoma es una lesión osteolítica destructiva con riesgo de parálisis facial, fístula laberíntica y abscesos intracraneales.
- El examen de elección para estudiar la anatomía y extensión del colesteatoma es el TAC de peñasco sin contraste.



EFUSIÓN: NIVEL DE LÍQUIDO
Bates, Guía de exploración física, Tabla 7-20

ALGORITMO · ALGORITMO DE ENFRENTAMIENTO: PATOLOGÍA CRÓNICA DEL OÍDO MEDIO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

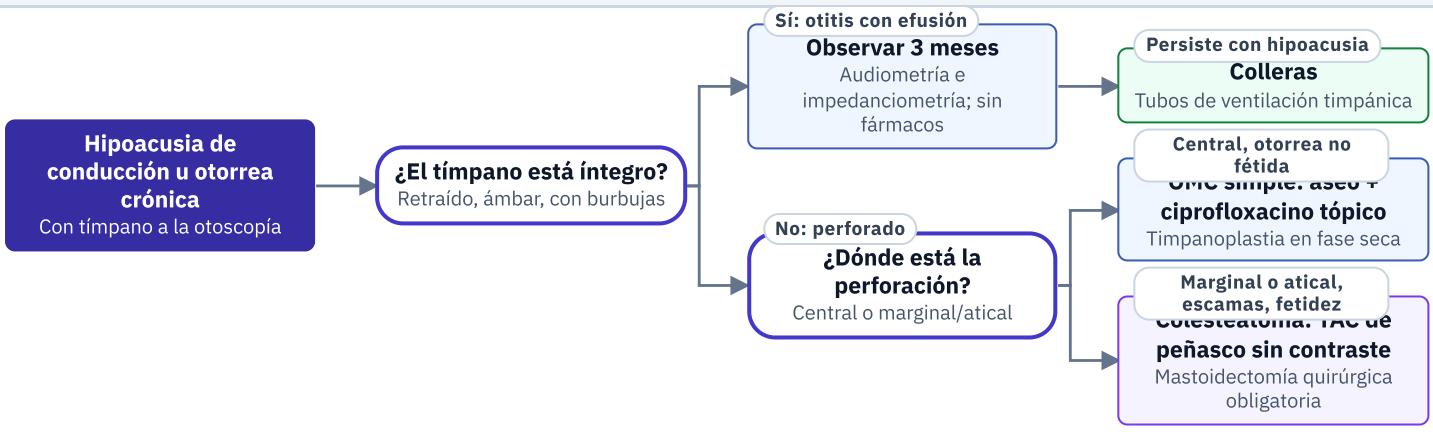


TABLA 14.2 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: OME VS OMC SIMPLE VS OMC COLESTEATOMATOSA

CARACTERÍSTICA CLÍNICA	OTITIS MEDIA CON EFUSIÓN (OME)	OMC SIMPLE (SUPURADA)	OMC COLESTEATOMATOSA
Estado Timpánico	Tímpano íntegro, retraído, color ámbar, burbujas visibles	Perforación central en pars tensa (respeta el annulus)	Perforación marginal en pars flácida o bolsillo de retracción atical
Otorrea	Ausente (líquido retenido detrás del tímpano)	Otorrea mucosa o purulenta no fétida, indolora	Otorrea fétida persistente con escamas nacaradas de queratina
Comportamiento Óseo	No osteolítico · Reversible espontáneamente	Rara vez osteolítico · Cadena típicamente conservada	Altamente osteolítico: erosión de huesecillos, laberinto y tegmen
Conducta Oficial	Observación 3 meses; colleras si persiste hipoacusia	Aseo + Ciprofloxacino tópico; timpanoplastia en fase seca	TAC de peñasco sin contraste + Mastoidectomía quirúrgica obligatoria

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

	OTITIS CON EFUSIÓN	OMC SIMPLE	COLESTEATOMA
Hueso	No es osteolítica; se resuelve sola	Rara vez osteolítica	Muy osteolítico

REGLA DE ORO **Observar 3 meses, sin fármacos** — Colleras si persiste con hipoacusia

PRACTICA **Libro Gordo Otorrinolaringología**, preguntas **13–15** (pág. 12) · solucionario pág. 27.

Clase 14.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · PATOLOGÍA DEL OÍDO EXTERNO Y MEDIO

14.3 Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos

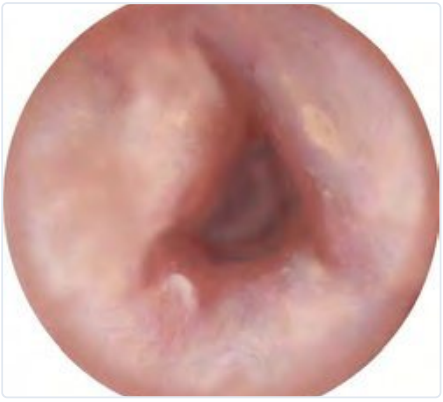
★★★ PRIORIDAD ALTA
10 preguntas reales 2013–2025

6.03.1.019 Otitis externa — Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar

También: Pié diabético y otras infecciones en diabetes · Prevención de otitis externa · Lavado de oídos · Otohematoma · Drenaje de otohematoma

LO QUE TE PREGUNTAN

- La otitis externa difusa aguda (oído de nadador) se trata con aseo del CAE y gotas óticas de Ciprofloxacino; NO requiere antibióticos orales.
- El dolor exquisito a la presión del trago (Signo del Trago +) y tracción del pabellón es característico de patología del CAE.
- La Otitis Externa Maligna es una osteomielitis de la base del cráneo causada por Pseudomonas aeruginosa en pacientes diabéticos descompensados.
- El hallazgo físico patognomónico de la otitis externa maligna es el tejido de granulación en el piso del conducto auditivo externo.
- El VII par craneal (facial) es el nervio craneano que se compromete con mayor frecuencia en la otitis externa maligna.



CONDUCTO EDEMATOSO
Bates, Guía de exploración física, Fig. 7-43

ALGORITMO · ALGORITMO DE ENFRENTAMIENTO: OTITIS EXTERNA

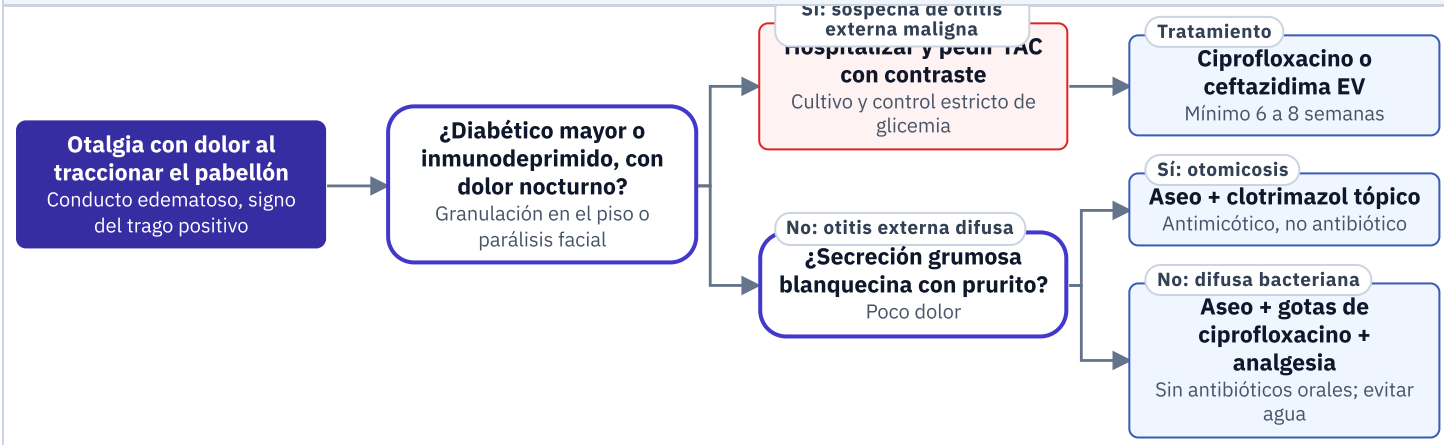


TABLA 14.3 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: OTITIS EXTERNA DIFUSA VS OTITIS EXTERNA MALIGNA

CRITERIO COMPARATIVO	OTITIS EXTERNA DIFUSA AGUDA	OTITIS EXTERNA MALIGNA (NECROTIZANTE)
Población de Riesgo	Cualquier edad, nadadores, usuarios de hisopos/cotonitos	Adultos mayores (> 65 años) diabéticos o inmunodeprimidos
Etiología Principal	Pseudomonas aeruginosa (70%) y S. aureus (20%)	Pseudomonas aeruginosa (> 95% de los casos)
Severidad del Dolor	Otalgia aguda moderada a severa, signo del trago (+)	Dolor terebrante intolerable, nocturno, que despierta al paciente
Hallazgo Otoscópico	Edema y eritema difuso del CAE con detritos descamativos	Tejido de granulación en el piso del CAE (unión osteocartilaginosa)
Compromiso Nervioso	Ausente · Función de pares craneales rigurosamente intacta	Frecuente parálisis del VII par craneal (facial); luego IX, X, XI, XII
Manejo Terapéutico	Ambulatorio: Gotas tópicas de Ciprofloxacino + analgesia oral	Hospitalario urgente: Ciprofloxacino o Ceftazidima EV x 6-8 semanas

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

	DIFUSA (NADADOR)	MALIGNA (NECROTIZANTE)
Quién	Cualquier edad; nadadores, cotonitos	Mayor de 65, diabético o inmunodeprimido

REGLA DE ORO **Aseo, gotas de ciprofloxacino, analgesia** — Sin antibióticos orales

PRACTICA **Libro Gordo Otorrinolaringología**, preguntas **16–18, 21** (págs. 12–13) · solucionario págs. 27–28.

Clase 14.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · PATOLOGÍA DEL OÍDO EXTERNO Y MEDIO

14.4 Complicaciones de Otitis: Mastoiditis Aguda y Tromboflebitis

★★★ PRIORIDAD ALTA
6 preguntas reales 2013–2025

6.03.2.001 Absceso mastoídeo de otitis media aguda y crónica — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Otitis media crónica y complicaciones · Drenaje de absceso mastoídeo

LO QUE TE PREGUNTAN

- La mastoiditis aguda es la complicación intratemporal más común de la OMA en la infancia.
- La tríada clínica definitoria es eritema/dolor retroauricular, borramiento del surco retroauricular y desplazamiento del pabellón auricular hacia adelante.
- Toda sospecha de mastoiditis aguda exige hospitalización inmediata.
- El TAC de peñasco con contraste es el patrón de oro imagenológico para confirmar la coalescencia ósea y descartar complicaciones endocraneales.
- El tratamiento inicial consiste en Ceftriaxona endovenosa en dosis altas (**100 mg/kg**/día) más miringotomía descompresiva.
- La presencia de absceso subperióstico fluctuante o falta de respuesta a antibióticos a las **24-48h** indica mastoidectomía quirúrgica urgente.



PABELLÓN DESPEGADO
Atlas of Clinical Emergency Medicine (Sherman), p. 229

ALGORITMO · ALGORITMO DE ENFRENTAMIENTO: MASTOIDITIS AGUDA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

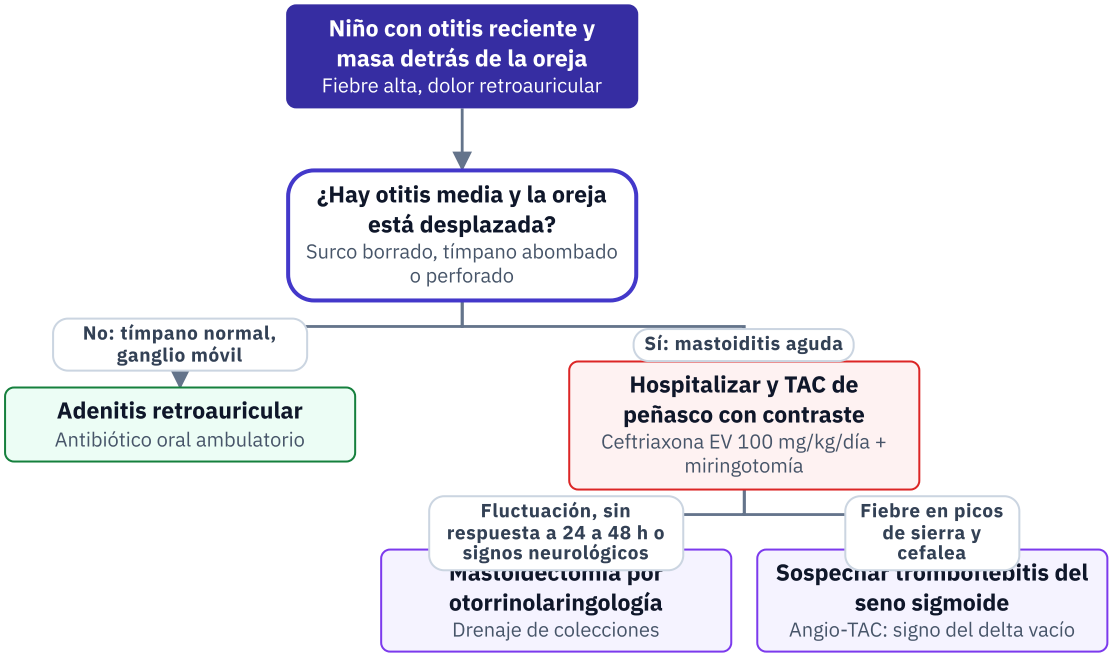


TABLA 14.4 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: MASTOIDITIS AGUDA VS ADENITIS RETROAURICULAR

CRITERIO DE EVALUACIÓN	MASTOIDITIS AGUDA COALESCENTE	ADENITIS RETROAURICULAR / CELULITIS
Otoscopía	OMA evidente: tímpano abombado o perforado con otorrea	Otoscopía rigurosamente normal (tímpano sano)
Surco Retroauricular	Borrado por el edema y colección subperióstica	Respetado; el ganglio es móvil o delimitado sobre el surco
Posición del Pabellón	Desplazado hacia adelante y hacia abajo ('oreja en asa')	Posición anatómica normal del pabellón auricular
TAC de Peñasco	Pérdida de trabéculas óseas y coalescencia mastoidea	Celdas mastoideas bien aireadas sin osteólisis
Conducta Médica	Hospitalización + Ceftriaxona EV + TAC de peñasco urgente	Ambulatorio: antibióticos orales (Cloxacilina o Cefadroxilo)

REGLA DE ORO **Oreja despegada y surco borrado** — Edema y dolor sobre la mastoides

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Otorrinolaringología**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 14.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · AUDIOLOGÍA & TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO

14.5 Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber)

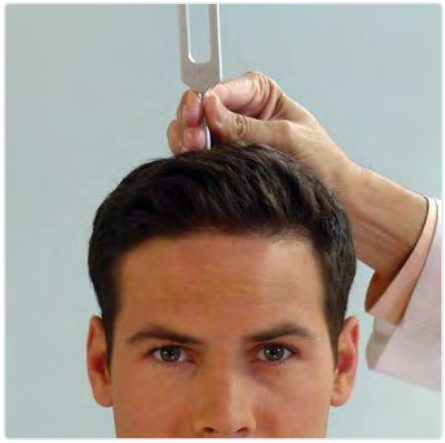
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
3 preguntas reales 2013–2025

6.03.4.006 Audiometría básica — Emplea informe

También: Impedanciometría básica · Diagnóstico diferencial de hipoacusias de transmisión · Diagnóstico diferencial de hipoacusias sensorioneurales · Hipoacusia

LO QUE TE PREGUNTAN

- En el Test de Weber, el sonido lateraliza al oído enfermo en hipoacusia de conducción y al oído sano en hipoacusia sensorioneural.
- En el Test de Rinne, un resultado negativo (VO > VA) es patognomónico de hipoacusia de conducción.
- En la hipoacusia sensorioneural, el Test de Rinne sigue siendo positivo (VA > VO).
- La brecha u oscilación óseo-aérea (Gap **≥ 15 dB**) en la audiometría tonal confirma compromiso mecánico del oído externo o medio.
- La curva B (plana) en la timpanometría es característica de Otitis Media con Efusión (líquido en la caja timpánica).
- La curva C (presión negativa < -100 daPa) es diagnóstica de disfunción de la trompa de Eustaquio.



PRUEBA DE WEBER
Bates, Guía de exploración física, Fig. 7-44

ALGORITMO · ALGORITMO DE INTERPRETACIÓN: DIAPASONES, AUDIOMETRÍA Y TIMPANOMETRÍA

☐ urgencia ☐ resuelve ☐ derivar ☐ examen/acción

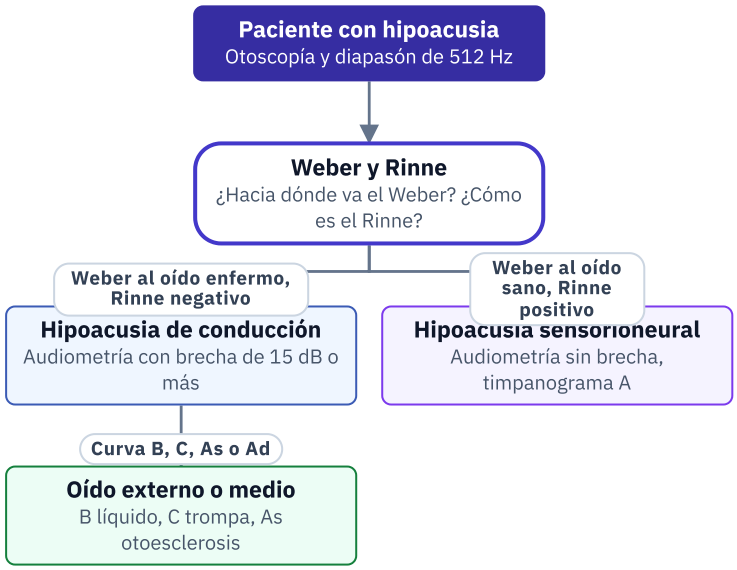


TABLA 14.5 · SÍNTESIS SEMIOLOGÍA DE PRUEBAS AUDITIVAS: DIAPASONES, AUDIOMETRÍA Y TIMPANOMETRÍA

PARÁMETRO / PRUEBA	AUDICIÓN NORMAL	HIPOACUSIA DE CONDUCCIÓN	HIPOACUSIA SENSORIONEURAL
Test de Weber	Indiferente / Centrado en línea media	Lateraliza al oído enfermo (peor audición)	Lateraliza al oído sano (mejor audición)
Test de Rinne	Positivo bilateral (VA > VO)	Negativo en oído enfermo (VO > VA)	Positivo en oído enfermo (VA > VO)
Audiometría Tonal	Ambas curvas ≤ 20 dB HL	Vía ósea normal + Vía aérea descendida (Gap ≥ 15 dB)	Ambas curvas descendidas juntas (Sin Gap)
Timpanograma Típico	Curva A de Jerger (Pico centrado en 0)	Curva B (plana por líquido) o Curva C (tubárica) o As	Curva A de Jerger rigurosamente normal
Reflejo Estapedial	Presente bilateralmente	Ausente al estimular el oído con patología de conducción	Presente si HSN es leve-moderada (con reclutamiento)

REGLA DE ORO **Weber: conducción al enfermo** — Sensorioneural al sano; Rinne negativo = conducción

PRACTICA **Libro Gordo Otorrinolaringología**, preguntas **22–25** (pág. 13) · solucionario pág. 28.

Clase 14.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · AUDIOLOGÍA & TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO

14.6 Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
5 preguntas reales 2013–2025

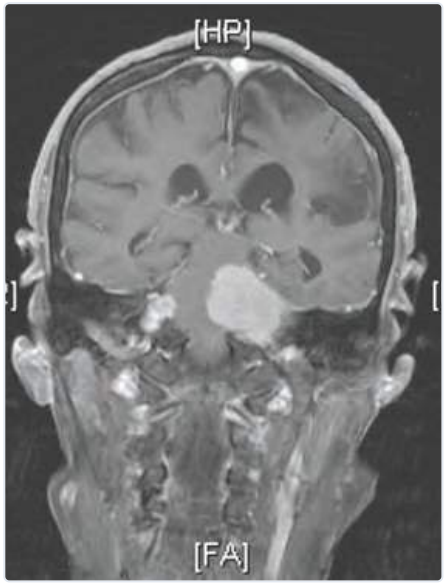
Altísima rentabilidad · 2 a 3 preguntas por examen: la hipoacusia sensorioneural súbita como URGENCIA MÉDICA tratada con corticoides precoces y la presbiacusia en el adulto mayor GES

6.03.2.018 **Sordera súbita** — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Diagnóstico diferencial de hipoacusias sensorioneurales · Barotrauma ótico y trauma acústico agudo · Prevención de trauma acústico y daño por exposición a ruidos · Tinitus · Perforación timpánica traumática · Estudio de VIII par

LO QUE TE PREGUNTAN

- La Hipoacusia Sensorioneural Súbita es una URGENCIA MÉDICA definida por una caída **≥ 30 dB** en **≥ 3 frecuencias** en < **72 horas**.
- Ante una hipoacusia brusca con otoscopía normal, el error más grave es atribuirla a cerumen o disfunción tubárica y observar.
- El único tratamiento con eficacia comprobada son los corticoides sistémicos en altas dosis (Prednisona **1 mg/kg**/día por **10-14 días**).
- La ventana de máxima eficacia para el inicio de corticoides son las primeras **48 a 72 horas** del cuadro.
- Todo paciente con HSNS debe ser estudiado con RMN de ángulo pontocerebeloso para descartar Schwannoma vestibular.
- El trauma acústico crónico ocupacional se manifiesta con una muesca o escotoma clásico en la frecuencia 4000 Hz.
- La presbiacusia produce hipoacusia HSN bilateral, simétrica y de tonos agudos en > **65 años**, cubierta por el programa GES N° 56.



SCHWANNOMA VESTIBULAR EN RM
Bailey & Love 27.ª ed., p. 687

ALGORITMO · ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE URGENCIA: HIPOACUSIA SENSORIONEURAL SÚBITA

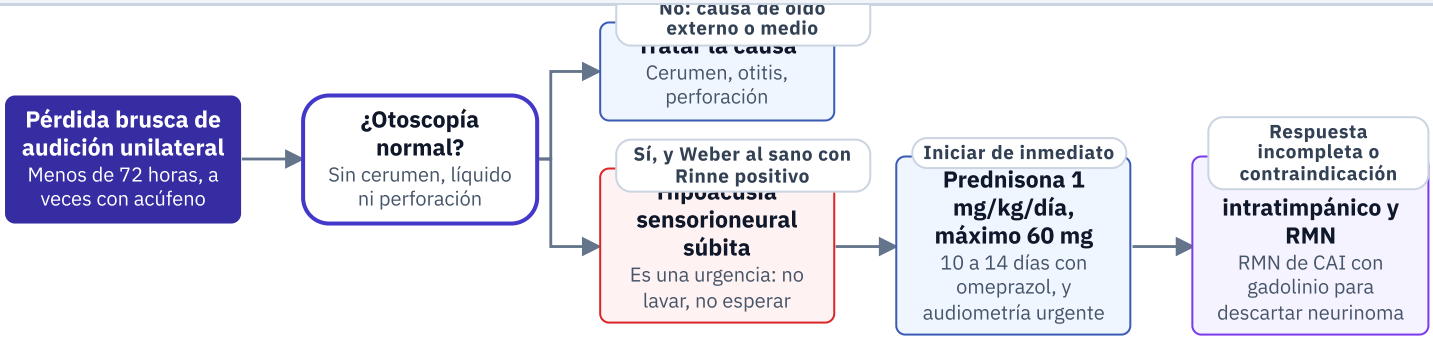


TABLA 14.6 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: HIPOACUSIA SÚBITA VS TRAUMA ACÚSTICO VS PRESBIACUSIA

ENTIDAD CLÍNICA	ETIOLOGÍA / FISIOPATOLOGÍA	PATRÓN AUDIOMÉTRICO TÍPICO	TRATAMIENTO / COBERTURA
Hipoacusia Sensorioneural Súbita	Idiopática (viral / microvascular) · Lesión coclear aguda	Caída HSN ≥ 30 dB en ≥ 3 frecuencias consecutivas unilateral	URGENCIA: Prednisona oral 1 mg/kg/día x 10-14 días precoz
Trauma Acústico Crónico	Exposición ocupacional repetida a ruido industrial > 85 dB	Muesca o escotoma sensorial selectivo en frecuencia 4000 Hz	Prevención: Protectores auditivos; daño ya instalado es irreversible
Presbiacusia del Adulto Mayor	Envejecimiento y degeneración de células ciliadas y estría vascular	HSN bilateral y simétrica descendente en frecuencias agudas	Garantía GES en ≥ 65 años: Implementación de audífonos
Neurinoma del Acústico (VIII)	Schwannoma benigno del nervio vestibular en el CAI	HSN unilateral progresiva con discriminación muy deteriorada	RMN con gadolinio · Microcirugía o radiocirugía estereotáxica

REGLA DE ORO **Pérdida brusca y otoscopía normal** — Prednisona 1 mg/kg desde el primer día

PRACTICA **Libro Gordo Otorrinolaringología**, preguntas **26–32, 56–57** (págs. 13–14, 18) · solucionario págs. 29, 33.

Clase 14.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · AUDIOLOGÍA & TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO

14.7 Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière

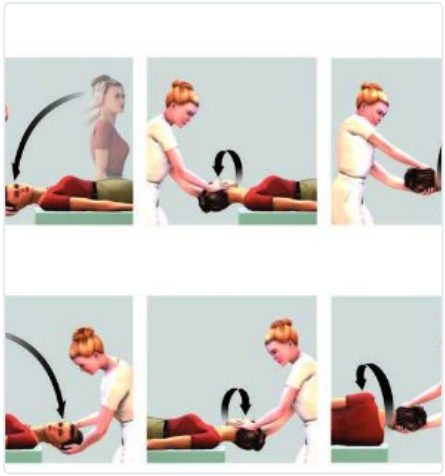
★★★ PRIORIDAD ALTA
7 preguntas reales 2013–2025

6.03.1.029 Síndrome vertiginoso — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Síndrome vertiginoso agudo · Síndromes vertiginosos periféricos

LO QUE TE PREGUNTAN

- El VPPB es la causa más común de vértigo periférico; se caracteriza por crisis de segundos (< **1 min**) desencadenadas por giros de la cabeza.
- La maniobra de Dix-Hallpike confirma el VPPB al observar nistagmo torsional geotrópico con latencia y fatigabilidad.
- El tratamiento del VPPB es mecánico mediante la maniobra de reposición de Epley; los fármacos están desaconsejados.
- La Neuronitis Vestibular produce vértigo continuo de **2 a 5 días** con nistagmo horizontal unidireccional y SIN hipoacusia.
- Los sedantes vestibulares en la neuronitis solo deben usarse por **48 horas** como máximo para no bloquear la compensación central.
- La Enfermedad de Ménière se distingue por crisis de **20 minutos** a horas con hipoacusia fluctuante sensorioneural en tonos graves y acúfenos.



MANIOBRA DE EPLEY
Harrison 21.ª ed., Fig. 22-1

ALGORITMO · ALGORITMO DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME VERTIGINOSO: PERIFÉRICO CONTRA CENTRAL

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

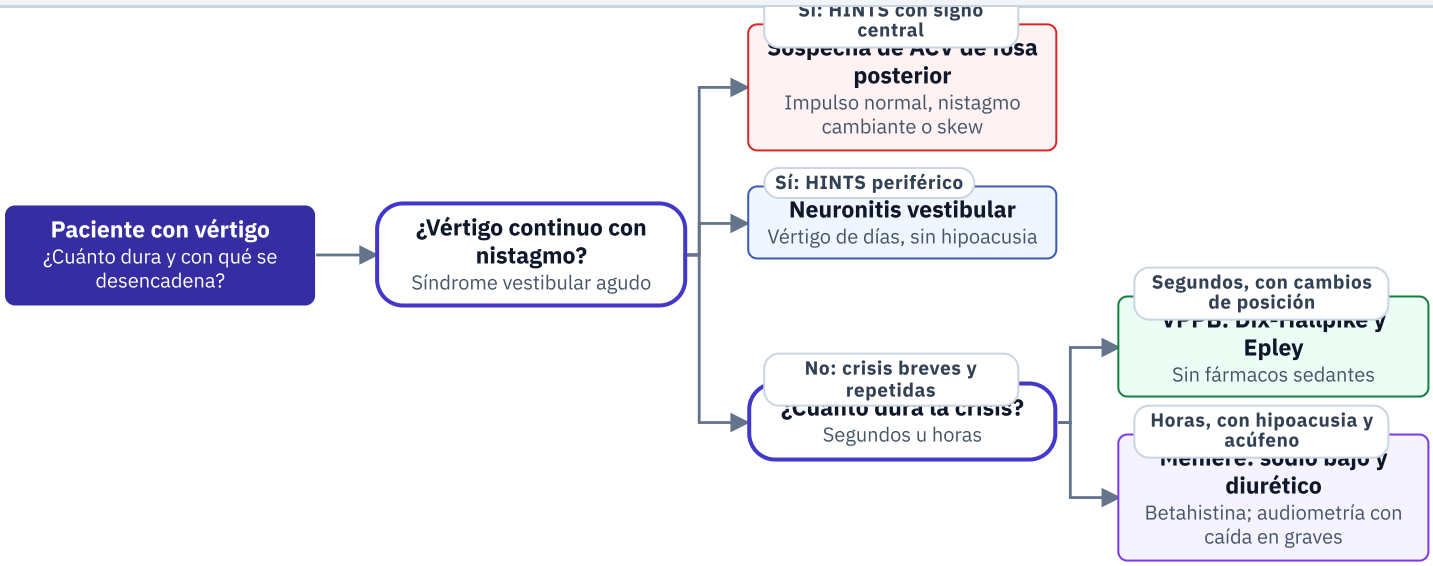


TABLA 14.7 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO DE LOS PRINCIPALES SÍNDROMES VERTIGINOSOS PERIFÉRICOS

CRITERIO COMPARATIVO	VPPB	NEURONITIS VESTIBULAR	ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE
Duración de la Crisis	Segundos (10 a 60 segundos por episodio)	Días (2 a 5 días de vértigo continuo continuo)	Horas (20 minutos a 12 horas; típica 2-4h)
Gatillante Principal	Cambios posturales cefálicos (giros en la cama)	Espontáneo tras cuadro viral respiratorio alto	Espontáneo, precedido de acúfeno y presión ótica
Síntomas Auditivos	Ninguno (audición rigurosamente normal)	Ninguno (oído medio e interno coclear indemnes)	Hipoacusia sensorioneural fluctuante en tonos graves + tinnitus
Hallazgo al Examen	Dix-Hallpike (+): nistagmo torsional geotrópico	Nistagmo horizontal unidireccional a oído sano	Audiometría con caída en frecuencias graves
Tratamiento de Elección	Maniobra de Epley / Semont (¡sin fármacos!)	Corticoides orales + reposo (sedantes máx 48h)	Restricción de sal (< 2 g/d) + Diuréticos / Betahistina

REGLA DE ORO **Segundos, días u horas** — VPPB, neuronitis y Ménière

PRACTICA **Libro Gordo Otorrinolaringología**, preguntas **33–36** (págs. 14–15) · solucionario pág. 30.

Clase 14.7 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · AUDIOLOGÍA & TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO

14.8 Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Síndrome de Ramsay Hunt

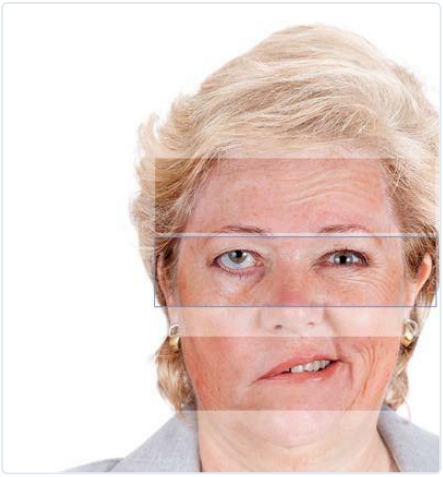
★☆☆
PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

1.10.1.016 Parálisis facial periférica — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Herpes zoster

LO QUE TE PREGUNTAN

- La parálisis facial periférica compromete la totalidad del hemicara ipsilateral, incluyendo la frente y el cierre ocular (lagoftalmos).
- La parálisis facial central respeta la musculatura de la frente gracias a la doble inervación corticonuclear bilateral.
- La Parálisis de Bell se trata con Prednisona oral a **1 mg/kg**/día durante **7 a 10 días** iniciada en las primeras **72 horas**.
- La protección de la córnea mediante lágrimas artificiales, ungüento lubricante y parche nocturno es mandataria en toda parálisis periférica.
- El Síndrome de Ramsay Hunt asocia parálisis periférica con otalgia severa y vesículas herpéticas en concha auricular y CAE.
- El tratamiento de Ramsay Hunt requiere la combinación precoz de Valaciclovir (**1000 mg** c/**8h**) o Aciclovir con Prednisona oral.



BELL DERECHA: LAGOFTALMOS
Manual AMIR Otorrinolaringología, p. 29

ALGORITMO · ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE LA PARÁLISIS FACIAL: CENTRAL CONTRA PERIFÉRICA

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

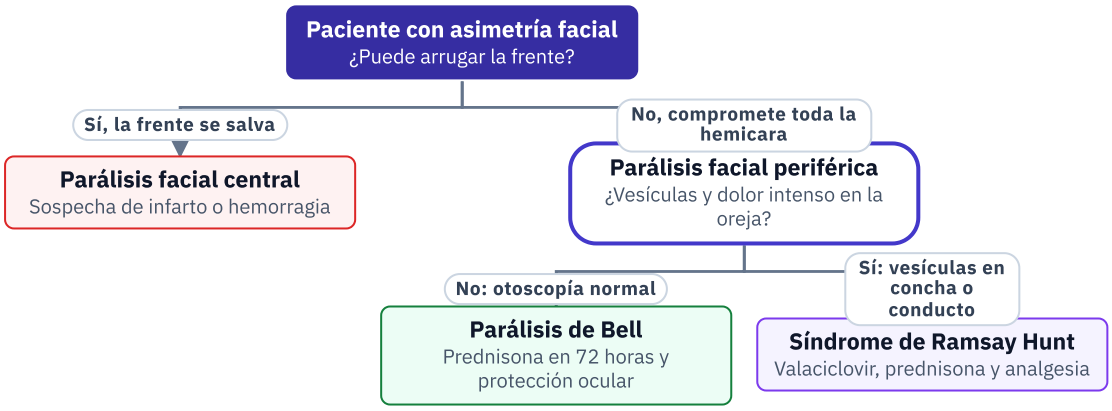


TABLA 14.8 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: PARÁLISIS DE BELL VS SÍNDROME DE RAMSAY HUNT VS ACV CENTRAL

CARACTERÍSTICA	PARÁLISIS DE BELL (IDIOPÁTICA)	SÍNDROME DE RAMSAY HUNT	PARÁLISIS FACIAL CENTRAL (ACV)
Afectación de la Frente	Comprometida (No arruga frente ni eleva ceja)	Comprometida (No arruga frente ni eleva ceja)	RESPETADA (Arruga frente y eleva ambas cejas)
Cierre Ocular (Lagoftalmos)	Presente (Signo de Bell positivo)	Presente (Lagoftalmos severo doloroso)	Normal (Cierre ocular simétrico y completo)
Examen Otológico	Otoscopía y pabellón rigurosamente normales	Vesículas herpéticas dolorosas en concha/CAE	Normal · Puede tener déficit motor de extremidades
Etiología Principal	Reactivación HSV-1 en nervio intratemporal	Reactivación VZV en ganglio geniculado	Infarto o hemorragia de arteria cerebral media/cortical
Tratamiento de Elección	Prednisona oral 1 mg/kg/d x 7-10d + Gotas oculares	Valaciclovir 1g c/8h + Prednisona 1 mg/kg/d x 10d	Activación Código ACV · Neuroimagen urgente

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

	BELL	RAMSAY HUNT	CENTRAL (ACV)
Causa	Herpes simple tipo 1	Varicela-zóster	Infarto o hemorragia

REGLA DE ORO **La frente decide** — Respetada: central. Comprometida: periférica

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Otorrinolaringología**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 14.8 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · RINOLOGÍA & SENOS PARANASALES

14.9 Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales

★★★ PRIORIDAD ALTA
6 preguntas reales 2013–2025

6.03.1.001 Alergia nasosinusal — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Rinitis alérgica · Rinorrea crónica · Pruebas cutáneas de alergia · Prevención de alergias nasosinusales

LO QUE TE PREGUNTAN

- La clasificación ARIA divide la rinitis alérgica en intermitente (< 4d/sem o < 4 sem) vs persistente (**≥ 4d/sem** y **≥ 4 sem**).
- La afectación del sueño, actividades o rendimiento laboral/escolar define a la rinitis como Moderada a Severa.
- Los corticoides intranasales (fluticasona, mometasona) son el fármaco de primera línea más eficaz para la rinitis alérgica moderada-severa.
- Los antihistamínicos orales de 2ª generación (cetirizina, desloratadina) no son sedantes y controlan prurito y estornudos, pero poco la congestión.
- La rinitis medicamentosa es causada por el uso de descongestionantes tópicos (oximetazolina) por más de **5 a 7 días**.
- El tratamiento de la rinitis medicamentosa es la suspensión inmediata del vasoconstrictor y el inicio de corticoides intranasales.



FACIES DE RINITIS ALÉRGICA
Bates, Guía de exploración clínica, p. 945

ALGORITMO · ALGORITMO TERAPÉUTICO DE LA RINITIS: ARIA Y RINITIS MEDICAMENTOSA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

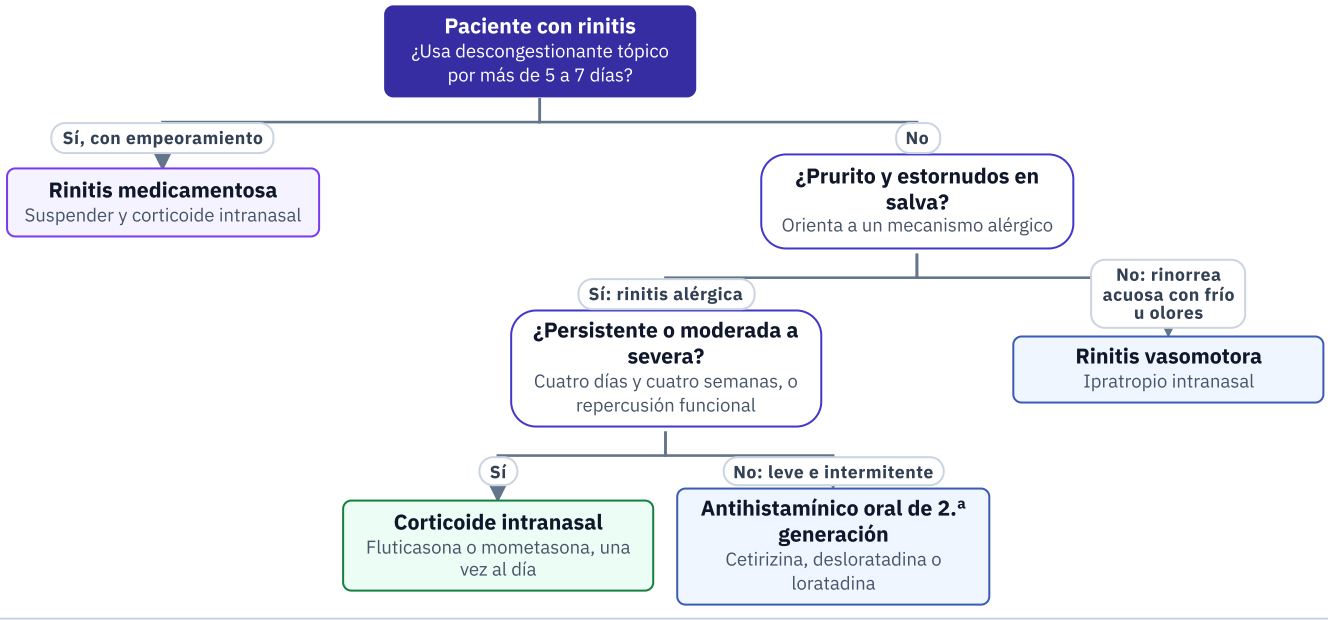


TABLA 14.9 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: RINITIS ALÉRGICA VS RINITIS NO ALÉRGICAS

ENTIDAD CLÍNICA	FISIOPATOLOGÍA / GATILLANTE	HALLAZGO CLÍNICO CLAVE	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Rinitis Alérgica	Mediada por IgE contra aeroalérgenos (pólenes, ácaros)	Prurito, estornudos en salva, mucosa pálida/edematosa	Corticoides intranasales (Fluticasona/Mometasona) ± Antihistamínicos H1
Rinitis Medicamentosa	Abuso crónico de oximetazolina tópica (> 5-7 días)	Congestión nasal severa de rebote, mucosa eritematosa violácea	Suspensión tajante del descongestionante tópico + Corticoides intranasales
Rinitis Vasomotora	Hiperreactividad parasimpática ante cambios de temperatura/olores	Rinorrea acuosa profusa al comer (gustatoria) o al frío, sin prurito	Bromuro de ipratropio intranasal en spray tópico
Rinitis Infecciosa Aguda	Infección viral aguda (Rinovirus, Coronavirus)	Rinorrea inicialmente mucosa luego mucopurulenta, odinofagia, fiebre	Lavados nasales con suero fisiológico + Paracetamol · Autolimitada

REGLA DE ORO **Persistente: 4 días y 4 semanas** — Moderada a severa: un solo criterio funcional

PRACTICA **Libro Gordo Otorrinolaringología**, preguntas **1, 52–54** (págs. 10, 17–18) · solucionario págs. 25, 33.

Clase 14.9 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · RINOLOGÍA & SENOS PARANASALES

14.10 Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias

★★★ PRIORIDAD ALTA
13 preguntas reales 2013–2025

2.01.1.029 Sinusitis — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

También: Rinorreas agudas · Celulitis periorbitaria · Radiografía de senos paranasales · Infecciones de las vías aéreas superiores · Sinusopatías crónicas · Radiografía de cavidades perinasales · TAC de cavidades perinasales

LO QUE TE PREGUNTAN

- **La rinosinusitis bacteriana se diagnostica con**: síntomas **≥ 10 días**, o empeoramiento tras mejoría (doble caída), o fiebre **≥ 39**°C con secreción purulenta > **3 días**.
- El color verdoso o purulento de la mucosidad nasal NO indica por sí solo infección bacteriana ni justifica antibióticos.
- La radiografía de senos paranasales está en desuso y no se recomienda para el diagnóstico de rinosinusitis aguda no complicada.
- El antibiótico oral de primera línea para la RSBA es la Amoxicilina (o Amoxicilina con Ácido Clavulánico) por **7 a 10 días**.
- La celulitis preseptal presenta párpado inflamado con motilidad ocular y agudeza visual rigurosamente normales.
- La celulitis orbitaria se distingue por proptosis (exoftalmos), oftalmoplejía dolorosa y quemosis conjuntival.



EDEMA PALPEBRAL, ETMOIDITIS
Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 46.47

ALGORITMO · ALGORITMO DE LA RINOSINUSITIS AGUDA Y SUS COMPLICACIONES ORBITARIAS

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



TABLA 14.10 · CLASIFICACIÓN DE CHANDLER DE COMPLICACIONES ORBITARIAS DE LA RINOSINUSITIS

ESTADIO CHANDLER	AFECTACIÓN ANATÓMICA	SIGNOS CLÍNICOS CLAVE	CONDUCTA MÉDICA INMEDIATA
I: Celulitis Preseptal	Tejido celular subcutáneo anterior al septum orbitario	Edema y eritema palpebral · Motilidad y visión normales	Amoxicilina-Clavulánico oral o Cefazolina EV si lactante
II: Celulitis Orbitaria	Grasa orbitaria profunda (posterior al septum)	Proptosis, oftalmoplejía dolorosa y quemosis	Hospitalización urgente + TAC de órbitas + Ceftriaxona EV
III: Absceso Subperióstico	Colección purulenta bajo el periostio orbitario / etmoides	Globo ocular desplazado hacia abajo y afuera, diplopía	TAC con contraste + Drenaje quirúrgico urgente por ORL
IV: Absceso Orbitario	Pus en el espacio conal/intraconal de la órbita	Oftalmoplejía completa, pérdida visual severa, amaurosis	Drenaje quirúrgico descompresivo de emergencia + Antibióticos EV
V: Trombosis Seno Cavernoso	Extensión retrógrada séptica a través de venas oftálmicas	Proptosis bilateral, compromiso pares III, IV, V1, VI, estupor	UCI, Ceftriaxona + Vancomicina + Heparina anticoagulante

REGLA DE ORO **10 días, doble caída, inicio severo** — Solo así se indica amoxicilina

PRACTICA **Libro Gordo Otorrinolaringología**, preguntas **20, 38, 40–41** (págs. 13, 15) · solucionario págs. 28, 30–31.

Clase 14.10 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · RINOLOGÍA & SENOS PARANASALES

14.11 Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos

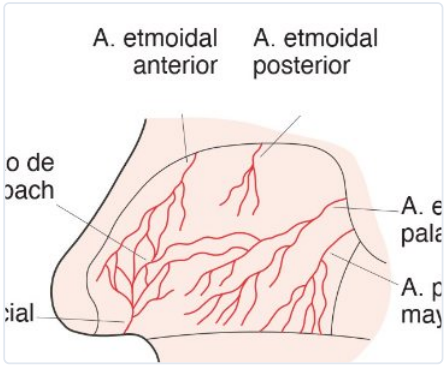
★☆☆
PRIORIDAD BAJA
0 preguntas reales 2013–2025

6.03.1.012 **Epistaxis leve** — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

También: Epistaxis masiva · Taponamiento nasal anterior · Taponamiento nasal posterior · Epistaxis · Epistaxis a repetición

LO QUE TE PREGUNTAN

- El **90%** de las epistaxis son anteriores y se originan en el Plexo de Kiesselbach (Área de Little) en el tabique anteroinferior.
- La primera medida obligatoria en epistaxis anterior es la compresión digital de las alas nasales con cabeza inclinada hacia adelante por **15 minutos**.
- Está terminantemente prohibido cauterizar ambos lados del tabique nasal simultáneamente por riesgo de perforación septal.
- El taponamiento anterior (Merocel o gasa) se retira habitualmente a las **48 horas**.
- La epistaxis posterior proviene habitualmente de la arteria esfenopalatina en adultos mayores hipertensos y fluye hacia la orofaringe.



IRRIGACIÓN DEL TABIQUE
Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 46.36

ALGORITMO · ALGORITMO DE MANEJO ESCALONADO DE LA EPISTAXIS

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

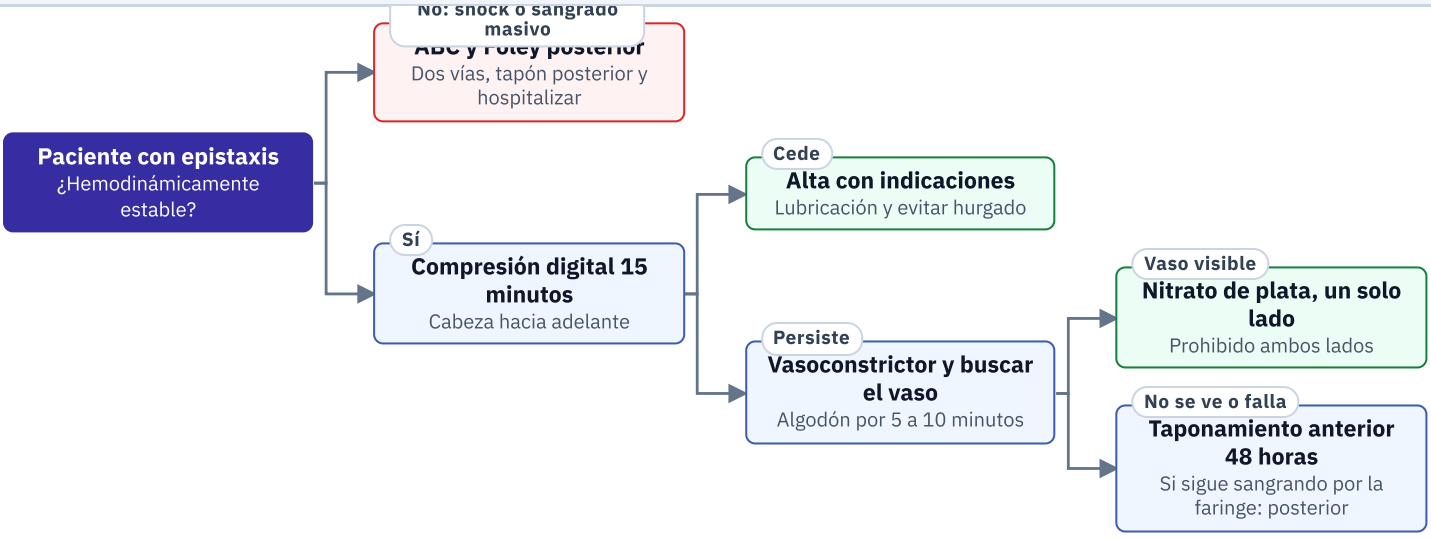


TABLA 14.11 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO Y MANEJO: EPISTAXIS ANTERIOR VS EPISTAXIS POSTERIOR

PARÁMETRO CLÍNICO	EPISTAXIS ANTERIOR (KIESSELBACH)	EPISTAXIS POSTERIOR (ESFENOPALATINA)
Frecuencia Relativa	90 a 95% de todas las consultas por epistaxis	5 a 10% de los casos (alta gravedad clínica)
Población Típica	Niños, adolescentes y adultos jóvenes sanos	Adultos mayores (> 60 años), hipertensos crónicos, aterosclerosis
Vaso Sanguíneo Causal	Plexo de Kiesselbach (Área de Little anteroinferior)	Arteria Esfenopalatina o ramas de la maxilar interna
Inspección Faríngea	Escasa o nula sangre en pared posterior faríngea	Flujo continuo y profuso de sangre roja fresca en orofaringe
Manejo Inicial de Elección	Compresión digital x 15 min -> Nitrato de plata -> Taponamiento anterior	Taponamiento posterior con Sonda Foley insuflada + Taponamiento anterior
Destino del Paciente	Ambulatorio (retiro de Merocel a las 48 horas)	Hospitalización OBLIGATORIA + Antibióticos EV/orales profilácticos

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

PARÁMETRO	ANTERIOR	POSTERIOR
Paciente típico	Niño o adulto joven sano	Mayor de 60, hipertenso, ateroesclerosis

REGLA DE ORO **Compresión, vasoconstrictor, nitrato de plata, tapón** — En ese orden, cabeza hacia adelante

PRACTICA **Libro Gordo Otorrinolaringología**, preguntas **42–48** (págs. 16–17) · solucionario págs. 31–32.

Clase 14.11 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · RINOLOGÍA & SENOS PARANASALES

14.12 Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal

★★★ PRIORIDAD ALTA
6 preguntas reales 2013–2025

6.03.1.024 Poliposis nasal — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Obstrucción nasal crónica · Fractura nasal reciente · Hematoma nasoseptal · Drenaje de hematoma nasoseptal

LO QUE TE PREGUNTAN

- En todo traumatismo nasal es obligatorio descartar hematoma septal mediante rinoscopía anterior.
- El hematoma septal se visualiza como un abombamiento fluctuante violáceo en el tabique y exige DRENAJE QUIRÚRGICO INMEDIATO.
- La falta de drenaje de un hematoma septal conduce a necrosis isquémica del cartílago y deformidad en 'silla de montar'.
- Los pólipos nasales son masas bilaterales translúcidas, indoloras e insensibles al tacto ('aspecto de uva pelada').
- **La Tríada de Samter (o Widal) consiste en**: poliposis nasal bilateral + asma bronquial + intolerancia severa a la Aspirina y AINEs.
- En la tríada de Samter están estrictamente prohibidos la aspirina y los AINEs por riesgo de broncoespasmo fatal.



LATERORRINIA TRAS UN GOLPE
Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 46.37

ALGORITMO · ALGORITMO DIAGNÓSTICO EN PATOLOGÍA ESTRUCTURAL Y OBSTRUCTIVA NASAL

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

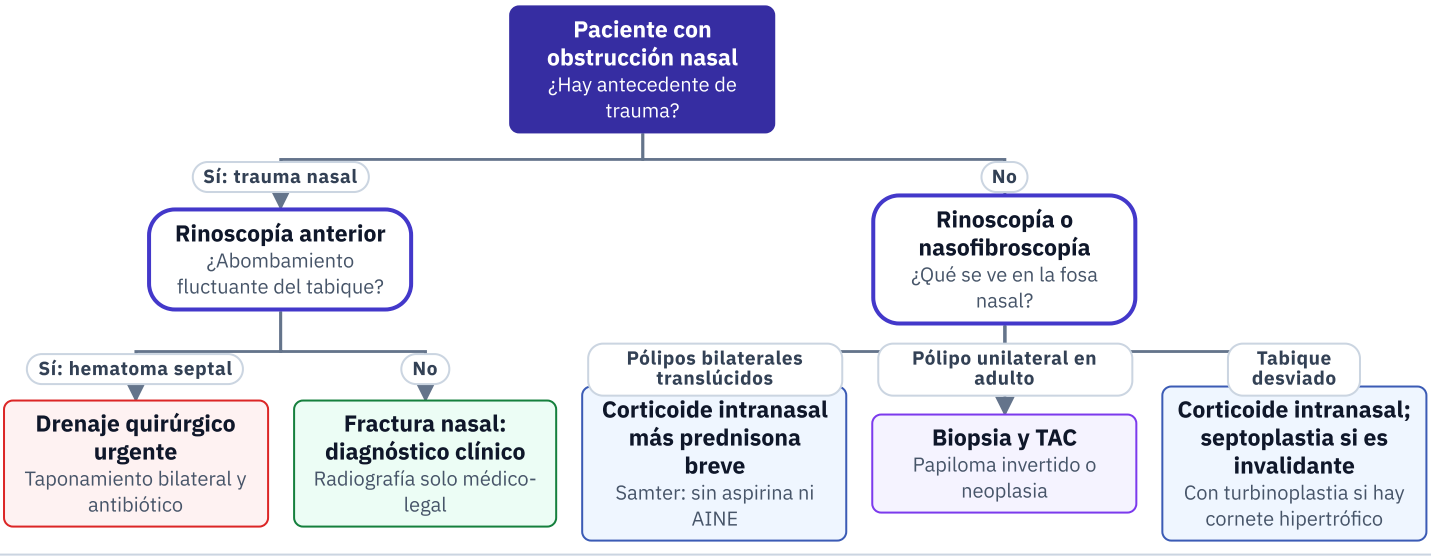


TABLA 14.12 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: POLIPOSIS NASAL VS CORNETE HIPERTRÓFICO VS HEMATOMA SEPTAL

LESIÓN ENDONASAL	ASPECTO A LA RINOSCOPÍA	SENSIBILIDAD AL TACTO	CONDUCTA TERAPÉUTICA INMEDIATA
Pólipo Nasal Benigno	Masa translúcida brillante, blanco-grisácea ('uva pelada')	COMPLETAMENTE INDOLORO y no sangra al tacto suave	Corticoides intranasales en altas dosis · Cirugía FESS si refractario
Cornete Inferior Hipertrófico	Mucosa eritematosa o rosada, consistencia firme elástica	MUY DOLOROSO y sensible al contacto con el estilete	Corticoides intranasales / Descongestionantes / Turbinoplastia
Hematoma Septal Agudo	Tumefacción abombada violácea, fluctuante y blanda en tabique	Doloroso a la palpación local tras antecedente traumático	URGENCIA: Drenaje quirúrgico inmediato + Taponamiento compresivo bilateral
Papiloma Invertido	Masa unilateral de aspecto cerebriforme o vegetante carnosa	Sangra con facilidad · Destrucción ósea local	Biopsia + Resección quirúrgica amplia por riesgo de carcinoma (10%)

REGLA DE ORO **Todo trauma: rinoscopía** — Descarta hematoma septal

PRACTICA **Libro Gordo Otorrinolaringología**, preguntas **3, 49–51** (págs. 10, 17) · solucionario págs. 25, 32.

Clase 14.12 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · FARINGE, LARINGE & VÍA AÉREA SUPERIOR

14.13 Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina

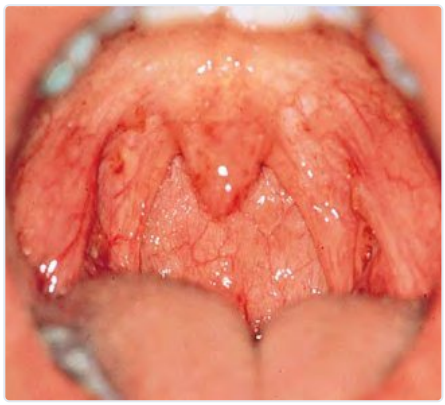
★★★
PRIORIDAD ALTA
21 preguntas reales 2013–2025

6.03.1.002 Amigdalitis aguda — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Odinofagias agudas · Faringoamigdalitis · Síndrome mononucleósico · Resfrío común · Enfermedad reumática activa · Prevención de enfermedad reumática · Pruebas rápidas para diagnóstico de estreptococo grupo A

LO QUE TE PREGUNTAN

- La presencia de tos, rinorrea, disfonía o conjuntivitis prácticamente descarta SBHGA y confirma etiología viral.
- **Los 4 criterios de Centor son**: fiebre > **38°C**, exudado amigdalino, adenopatías cervicales anteriores dolorosas y ausencia de tos.
- **La escala de McIsaac añade el factor edad**: **3-14 años** (+1), **15-44 años** (0), **≥ 45 años** (-1).
- El tratamiento de primera línea es Penicilina Benzatina IM dosis única o Amoxicilina oral por 10 DÍAS COMPLETOS.
- El objetivo prioritario del tratamiento antibiótico es la prevención de la Fiebre Reumática Aguda.



FARINGE ROJA SIN EXUDADO
Bates, Guía de exploración física, Tabla 7-23

ALGORITMO · ALGORITMO DE LA FARINGOAMIGDALITIS AGUDA SEGÚN MCISAAC

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción



TABLA 14.13 · CRITERIOS CLÍNICOS DE MCISAAC Y PROBABILIDAD DE FARINGITIS ESTREPTOCÓCICA (SBHGA)

PUNTUACIÓN TOTAL	PROBABILIDAD DE SBHGA	CONDUCTA DIAGNÓSTICA OFICIAL	TRATAMIENTO RECOMENDADO
0 a 1 punto	< 5% en adultos; < 10% en niños	No requiere test microbiológico ni cultivo	Sintomático exclusivo: Paracetamol / Ibuprofeno
2 puntos	10 a 17%	Test rápido de antígeno estreptocócico o cultivo	Tratar solo si el test de laboratorio es positivo
3 puntos	25 a 35%	Test rápido de antígeno estreptocócico o cultivo	Tratar solo si el test de laboratorio es positivo
4 a 5 puntos	50 a 60%	Test rápido / Cultivo o Tratamiento empírico directo	Penicilina Benzatina IM dosis única o Amoxicilina x 10 días

TRAMPAS EUNACOM

CARACTERÍSTICA	VIRAL	ESTREPTOCOCO	MONONUCLEOSIS
Vía aérea	Tos, rinorrea, disfonía, aftas	Sin tos ni coriza	Sin tos; odinofagia intensa y prolongada
Exudado	Raro o puntiforme	Placas pultáceas confluentes	Extenso, con membranas gruesas
Adenopatías	Submandibulares pequeñas	Anteriores muy dolorosas	Posteriores, axilares y esplenomegalia

REGLA DE ORO **Tos o coriza: es viral** — Sin antibiótico

PRACTICA **Libro Gordo Otorrinolaringología**, preguntas **58–63, 73** (págs. 18–19, 21) · solucionario págs. 33–34, 36.

Clase 14.13 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · FARINGE, LARINGE & VÍA AÉREA SUPERIOR

14.14 Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
4 preguntas reales 2013–2025

6.03.2.002 Absceso periamigdalino — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

También: Drenaje de absceso periamigdaliano · Absceso retrofaríngeo · Absceso profundo de cuello · Absceso amigdalino · TAC cervical con contraste · Drenaje de absceso retrofaríngeo

LO QUE TE PREGUNTAN

- **La tríada del absceso periamigdalino es**: trismus, voz en 'papa caliente' y desviación de la úvula hacia el lado contralateral.
- El trismus se produce por irritación inflamatoria del músculo pterigoideo interno contiguo al pilar amigdalino.
- El tratamiento inicial mandatario del absceso periamigdalino es la punción o incisión y drenaje en el punto de mayor abombamiento.
- El esquema antibiótico del absceso periamigdalino debe cubrir estreptococos y anaerobios orales (Amoxicilina-Clavulánico o Penicilina + Metronidazol).
- El absceso retrofaríngeo es típico de niños < **5 años** por supuración de ganglios de Gilette; se manifiesta con tortícolis, estridor y ensanchamiento prevertebral.
- El mayor peligro del absceso retrofaríngeo es la mediastinitis necrotizante descendente a través del danger space.
- La Angina de Ludwig es una celulitis del piso de la boca que eleva la lengua; la prioridad absoluta es ASEGURAR LA VÍA AÉREA.



PILAR ABOMBADO Y ÚVULA
Atlas of Clinical Emergency Medicine (Sherman), p. 259

ALGORITMO · ALGORITMO DE LAS INFECCIONES PROFUNDAS DEL CUELLO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

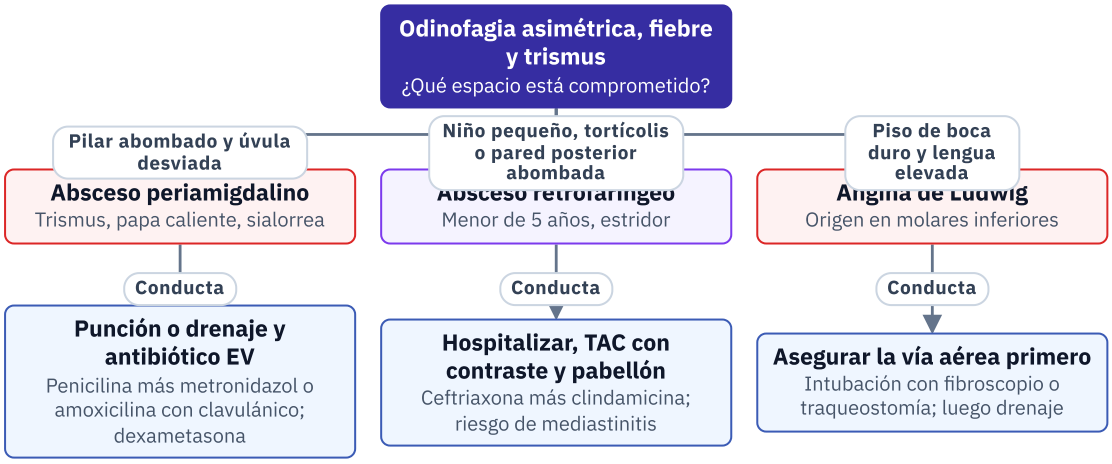


TABLA 14.14 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE INFECCIONES CERVICALES PROFUNDAS

ENTIDAD INFECCIOSA	POBLACIÓN TÍPICA	SIGNOS CLÍNICOS CARDINALES	COMPLICACIÓN MAYOR / CONDUCTA
Absceso Periamigdalino	Adolescentes y adultos jóvenes (15-35 años)	Trismus, voz en papa caliente, úvula desviada al lado sano	Punción/drenaje con aguja en box + Penicilina+Metronidazol EV
Absceso Retrofaríngeo	Lactantes y preescolares (< 5 años)	Tortícolis, estridor, abombamiento pared posterior faríngea	Mediastinitis descendente · TAC con contraste + Pabellón urgente
Absceso Parafaríngeo	Cualquier edad tras faringitis u otitis	Trismus, tumefacción bajo ángulo mandibular, masa cervical	Erosión carotídea y Síndrome de Lemierre · Drenaje quirúrgico
Angina de Ludwig	Adultos con infección de molares inferiores	Induración leñosa de piso de boca con elevación de la lengua	ASFIXIA INMINENTE: Asegurar vía aérea + Traqueostomía + Drenaje

REGLA DE ORO **Trismus + papa caliente + úvula** — Absceso periamigdalino

PRACTICA **Libro Gordo Otorrinolaringología**, preguntas **64–70** (págs. 20–21) · solucionario págs. 34–35.

Clase 14.14 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · FARINGE, LARINGE & VÍA AÉREA SUPERIOR

14.15 Hipertrofia Adenotonsilar y SAHOS Infantil: Indicaciones Quirúrgicas

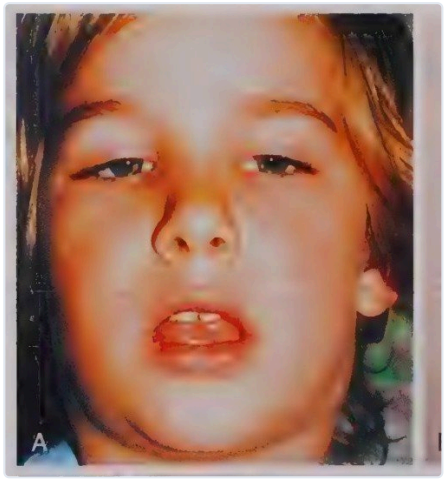
★☆☆
PRIORIDAD BAJA
2 preguntas reales 2013–2025

2.01.1.100 Hipertrofia adenoidea/amigdalina — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Síndrome de apnea del sueño · Síndrome respirador bucal · Radiografía de cavum · Amigdalitis crónica

LO QUE TE PREGUNTAN

- La hipertrofia adenotonsilar es la causa más común de SAHOS en niños entre 2 y **6 años**.
- El SAHOS infantil se manifiesta por ronquido nocturno, apneas presenciadas, sudoración y facies adenoidea.
- A diferencia del adulto, los niños con SAHOS presentan hiperactividad e irritabilidad diurna más que somnolencia.
- El SAHOS infantil severo es la indicación absoluta número uno de adenoamigdalectomía quirúrgica.
- Las amígdalas grado 4 de Brodsky ('amígdalas en beso') se tocan entre sí en la línea media ocluyendo > **75%** de la vía aérea.
- Los criterios de Paradise para amigdalectomía por infecciones son: **≥ 7 en** 1 año, **≥ 5/año** en **2 años**, o **≥ 3/año** en **3 años**.



FACIES ADENOIDEA
Zitelli and Davis' Atlas of Pediatric Physical Diagnosis, p. 952

ALGORITMO · ALGORITMO DEL NIÑO CON HIPERTROFIA ADENOTONSILAR Y SAHOS

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



TABLA 14.15 · ESCALA DE BRODSKY PARA CLASIFICACIÓN DE LA HIPERTROFIA DE AMÍGDALAS PALATINAS

GRADO DE BRODSKY	OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA	HALLAZGO FÍSICO EN OROFARINGE	RELEVANCIA QUIRÚRGICA
Grado 0	0% (Amígdalas ausentes)	Amigdalectomía previa o amígdalas en fosas profundas	Sin repercusión clínica
Grado 1	< 25% de la orofaringe	Amígdalas confinadas a las fosas amigdalinas	Normal fisiológico
Grado 2	25 a 50% de la orofaringe	Amígdalas sobrepasan los pilares anteriores pero no tocan línea media	Común en niños · Observación
Grado 3	50 a 75% de la orofaringe	Amígdalas ocupan más de la mitad del espacio orofaríngeo	Frecuente respirador bucal · Evaluar SAHOS
Grado 4	> 75% ('Amígdalas en beso')	Amígdalas se tocan entre sí en la línea media	ALTA indicación quirúrgica por riesgo de apneas obstructivas

REGLA DE ORO **Niño que ronca con apneas** — SAHOS: hiperactivo, no somnoliento

PRACTICA **Libro Gordo Otorrinolaringología**, pregunta **71** (pág. 21) · solucionario pág. 36.

Clase 14.15 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · FARINGE, LARINGE & VÍA AÉREA SUPERIOR

14.16 Disfonía Crónica y Patología Benigna de Cuerdas Vocales: Nódulos, Pólipos y Edema de Reinke

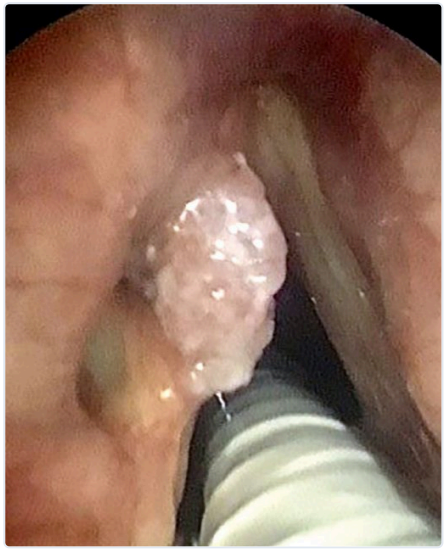
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
3 preguntas reales 2013–2025

6.03.1.010 Disfonías crónicas — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Laringoscopía indirecta · Disfonías agudas

LO QUE TE PREGUNTAN

- Toda disfonía que dure más de **2 a 3 semanas** exige laringoscopía para descartar cáncer escamoso de laringe.
- Los nódulos vocales son bilaterales y simétricos, localizados en la unión del tercio anterior con los dos tercios posteriores.
- El tratamiento de primera línea de los nódulos vocales es la TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA (no la cirugía).
- El pólipo vocal es unilateral y requiere microcirugía laríngea resectiva.
- El edema de Reinke produce voz grave 'de hombre' en mujeres con tabaquismo crónico masivo; se trata con cese del tabaco y cirugía.
- El granuloma de contacto se localiza en la apófisis vocal posterior del cartílago aritenoides, asociado a intubación previa o RGE.
- La parálisis de cuerda vocal unilateral en posición paramediana orienta a lesión del nervio laríngeo recurrente (sospechar cáncer de tiroides o pulmón).



CARCINOMA DE CUERDA VOCAL
Kumar and Clark's Clinical Medicine, p. 640

ALGORITMO · ALGORITMO DE LA DISFONÍA CRÓNICA Y LESIONES BENIGNAS DE CUERDAS VOCALES

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

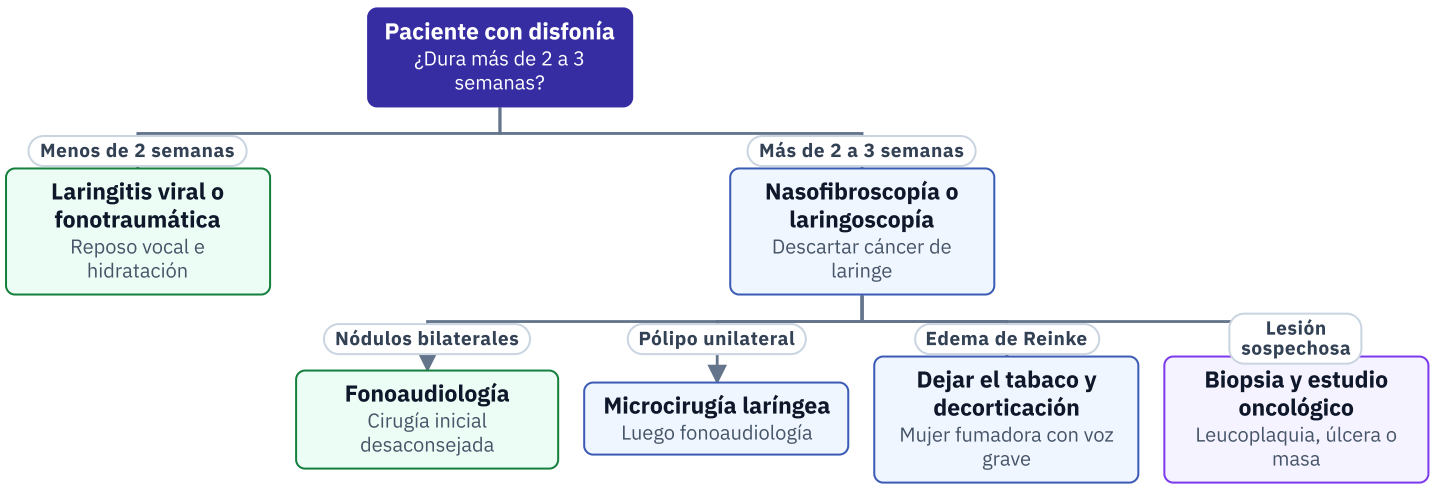


TABLA 14.16 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: NÓDULOS VOCALES VS PÓLIPO VOCAL VS EDEMA DE REINKE

LESIÓN DE CUERDA VOCAL	LATERALIDAD Y UBICACIÓN	POBLACIÓN Y CAUSA PRINCIPAL	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Nódulos Vocales	BILATERALES y simétricos · Unión 1/3 anterior con 2/3 posteriores	Profesores, cantantes · Mal uso y abuso vocal crónico	REHABILITACIÓN FONOAUDIOLÓGICA (Cirugía inicialmente desaconsejada)
Pólipo Vocal	UNILATERAL · Pediculado o sésil en borde libre	Hombres adultos · Esfuerzo vocal agudo violento (grito)	MICROCIRUGÍA LARÍNGEA (Fonocirugía) + Fonoaudiología postoperatoria
Edema de Reinke	Bilateral difuso · Cuerdas vocales gelatinosas abombadas	Mujeres fumadoras crónicas severas · Reflujo ácido	Cese estricto del tabaco + Decorticación quirúrgica / Aspiración
Úlcera / Granuloma de Contacto	Unilateral o bilateral sobre la apófisis vocal del aritenoides	Intubación endotraqueal previa traumática o reflujo severo	Inhibidores de bomba de protones (Omeprazol) + Reposo vocal

REGLA DE ORO **Cambio en tono, timbre o intensidad** — O fatiga vocal

PRACTICA **Libro Gordo Otorrinolaringología**, preguntas **19, 37, 72** (págs. 12, 15, 21) · solucionario págs. 28, 30, 36.

Clase 14.16 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · FARINGE, LARINGE & VÍA AÉREA SUPERIOR

14.17 Croup / Laringitis Obstructiva vs Epiglotitis Aguda: Escala de Taussig y Manejo de Emergencia

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
5 preguntas reales 2013–2025

2.01.1.025 Laringitis — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Obstrucción de vía aérea superior · Estridor laríngeo · Estridor congénito

LO QUE TE PREGUNTAN

- El Croup viral (laringotraqueítis) es causado en > **75%** por Virus Parainfluenza tipo 1 en niños de **6 meses** a **3 años**.
- **La tríada del croup es**: tos perruna, estridor inspiratorio y disfonía.
- La Dexametasona oral (**0.15 a 0.6 mg/kg**) en dosis única es obligatoria en TODOS los grados de croup (incluso leves).
- La Adrenalina nebulizada (corriente 1:1.000 **4 mL** o racémica) está indicada ante estridor presente en REPOSO (Taussig ≥ II).
- Todo niño nebulizado con adrenalina debe observarse por un mínimo estricto de **2 a 4 horas** para descartar efecto rebote.



ESTRECHAMIENTO SUBGLÓTICO
Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 3220

ALGORITMO · ALGORITMO DEL NIÑO CON ESTRIDOR: CROUP SEGÚN TAUSSIG Y EPIGLOTITIS

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

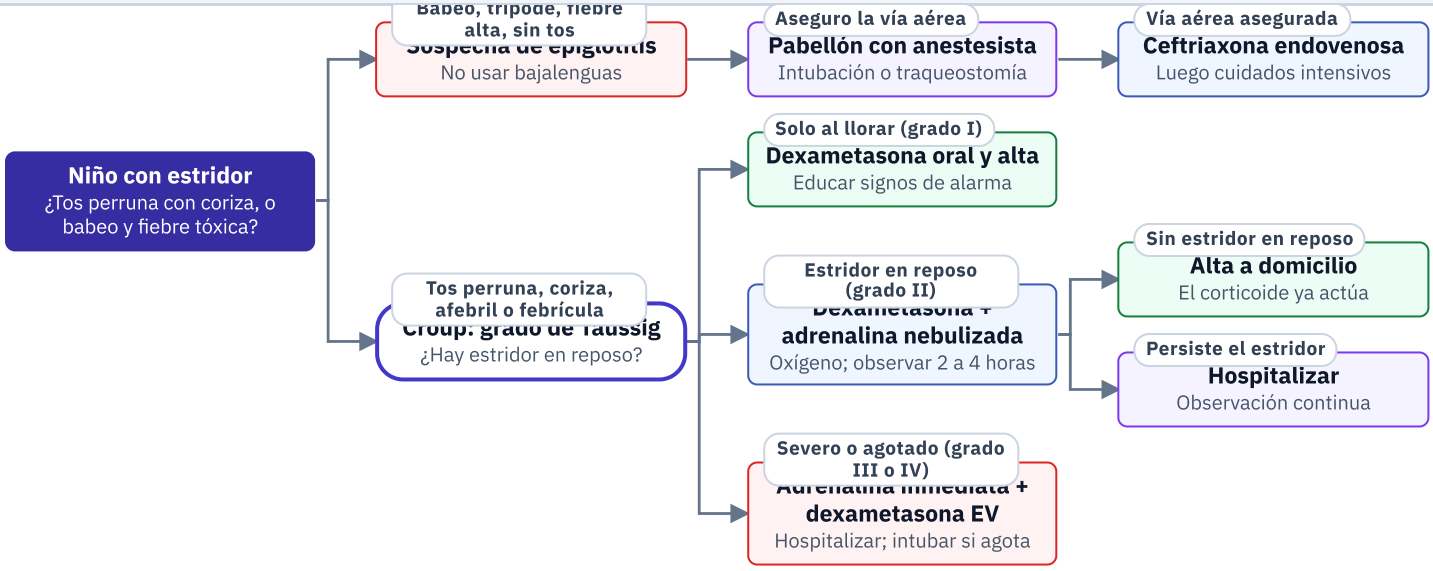


TABLA 14.17 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: LARINGITIS OBSTRUCTIVA (CROUP) VS EPIGLOTITIS AGUDA

PARÁMETRO CLÍNICO	LARINGITIS OBSTRUCTIVA AGUDA (CROUP)	EPIGLOTITIS AGUDA FULMINANTE
Etiología Principal	Viral: Virus Parainfluenza tipo 1 (75%)	Bacteriana: H. influenzae tipo b, S. pyogenes, S. pneumoniae
Edad Típica	6 meses a 3 años (pico en otoño/invierno)	2 a 7 años y adultos jóvenes
Comienzo / Pródromo	Progresivo (1-2 días de coriza y febrícula)	Hiperagudo y fulminante (horas de evolución con fiebre alta)
Tos y Voz	TOS PERRUNA áspera, disfonía marcada	AUSENCIA DE TOS; voz gangosa o apagada ('voz de papa caliente')
Signos Patognomónicos	Estridor inspiratorio rudo con tos metálica	SIALORREA / BABEO continuo y POSTURA EN TRÍPODE
Examen Físico Orofaríngeo	Faringe ligeramente congestiva (seguro de examinar)	¡TERMINANTEMENTE PROHIBIDO DEPRIMIR LA LENGUA!
Tratamiento de Urgencia	Dexametasona oral/EV + Adrenalina nebulizada	Aseguramiento de vía aérea en quirófano + Ceftriaxona EV

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	CROUP	EPIGLOTITIS
Causa y edad	Virus parainfluenza; 6 meses a 3 años	Bacteria; 2 a 7 años y adultos

REGLA DE ORO **Tríada: tos perruna, estridor, disfonía** — Parainfluenza; 6 meses a 3 años

PRACTICA **Libro Gordo Otorrinolaringología**, pregunta **55** (pág. 18) · solucionario pág. 33.

Clase 14.17 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · CUERPOS EXTRAÑOS, GLÁNDULAS SALIVALES & ONCOLOGÍA CERVICAL

14.18 Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea

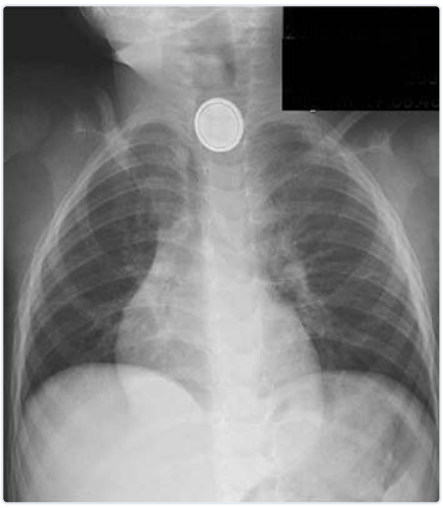
★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

6.03.2.008 Cuerpo extraño en el esófago — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Cuerpo extraño nasal · Cuerpo extraño en el oído · Cuerpo extraño en vía aérea · Prevención de cuerpo extraño en niños · Extracción de cuerpo extraño del oído · Extracción de cuerpo extraño nasal

LO QUE TE PREGUNTAN

- La pila de botón en fosa nasal o CAE es una emergencia quirúrgica absoluta por riesgo de perforación y necrosis en < **2 horas**.
- En cuerpos extraños por pilas de botón está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO irrigar con agua o suero.
- Un niño pequeño con rinorrea purulenta unilateral y de mal olor tiene un CUERPO EXTRAÑO NASAL hasta demostrar lo contrario.
- En cuerpos extraños esféricos nasales se usa un gancho romo por detrás; están contraindicadas las pinzas quirúrgicas lisas.
- En cuerpos extraños vegetales (semillas, porotos) en el CAE está prohibido el lavado con agua porque se hinchan.
- Ante un insecto vivo en el CAE, la primera medida obligatoria es ahogarlo con vaselina líquida o lidocaína.



PILA: DOBLE CONTORNO
The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 490

ALGORITMO · ALGORITMO DE MANEJO DE CUERPOS EXTRAÑOS EN OÍDO, NARIZ Y VÍA AÉREA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

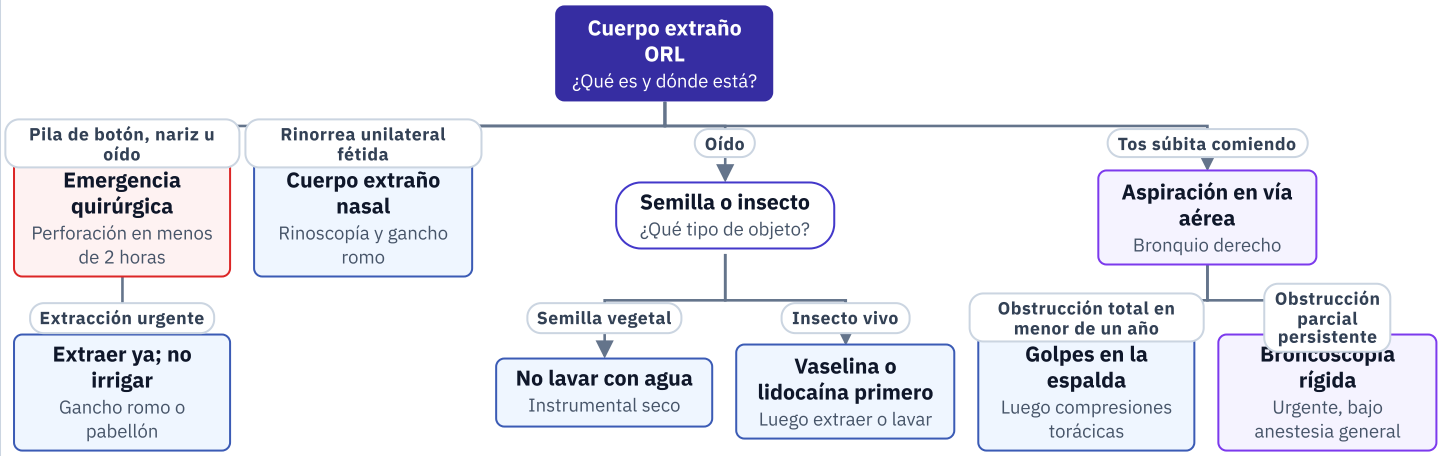


TABLA 14.18 · SÍNTESIS DE CONDUCTA DE URGENCIA EN CUERPOS EXTRAÑOS OTORRINOLARINGOLÓGICOS

TIPO DE CUERPO EXTRAÑO	LOCALIZACIÓN	PELIGRO INMINENTE / SIGNO CLAVE	CONDUCTA MÉDICA OFICIAL
Pila de Botón (Batería)	Fosa nasal o CAE	Necrosis alcalina y perforación septal/timpánica en < 2h	URGENCIA MÁXIMA: Extracción inmediata · ¡PROHIBIDO IRRIGAR!
Cuerpo Extraño Desapercibido	Fosa nasal unilateral	Rinorrea purulenta UNILATERAL FÉTIDA en preescolar	Rinoscopía anterior y extracción con gancho romo por detrás
Semilla / Poroto vegetal	Conducto Auditivo Externo	Maceración e hinchazón masiva si entra en contacto con agua	¡PROHIBIDO LAVADO CON AGUA! Extracción con instrumental seco
Insecto Vivo Móvil	Conducto Auditivo Externo	Dolor atroz por aleteo contra el tímpano	Instilar vaselina líquida o lidocaína para ahogarlo, luego lavar
Fruto Seco (Maní / Nuez)	Bronquio principal derecho	Síndrome de penetración, sibilancias unilaterales, atelectasia	BRONCOSCOPÍA RÍGIDA DE URGENCIA en pabellón quirúrgico

REGLA DE ORO **Pila de botón: no irrigar** — Extracción inmediata; perfora en 2 horas

PRACTICA **Libro Gordo Otorrinolaringología**, preguntas **75–80** (pág. 22) · solucionario págs. 36–37.

Clase 14.18 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · CUERPOS EXTRAÑOS, GLÁNDULAS SALIVALES & ONCOLOGÍA CERVICAL

14.19 Patología de Glándulas Salivales: Sialolitiasis, Parotiditis y Adenoma Pleomorfo

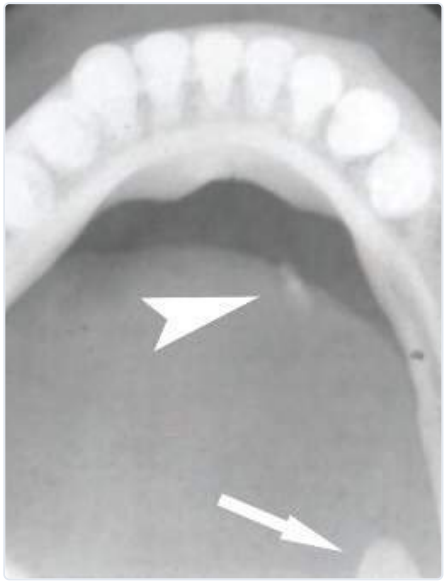
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
3 preguntas reales 2013–2025

6.03.1.023 Patología de glándulas salivales — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Patología glándulas salivales

LO QUE TE PREGUNTAN

- El **80-90%** de las sialolitiasis se localizan en la Glándula Submandibular a lo largo del conducto de Wharton.
- El cólico salival se caracteriza por dolor y aumento de volumen súbito submandibular durante la ingesta de alimentos.
- La parotiditis bacteriana aguda por S. aureus se presenta en ancianos deshidratados con salida de pus por el conducto de Stenon.
- El **80%** de los tumores de glándulas salivales asientan en la parótida, el **80%** son benignos y el **80%** son adenomas pleomorfos.
- El adenoma pleomorfo es una masa parotídea móvil e indolora de crecimiento lento que NUNCA compromete el nervio facial.
- La presencia de parálisis del nervio facial en una masa parotídea es signo patognomónico de CÁNCER MALIGNO.
- El tratamiento del adenoma pleomorfo es la parotidectomía superficial con preservación estricta del nervio facial (la enucleación simple está prohibida).



CÁLCULO EN EL WHARTON
Bailey & Love 27.ª ed., p. 802

ALGORITMO · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO EN PATOLOGÍA DE GLÁNDULAS SALIVALES

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

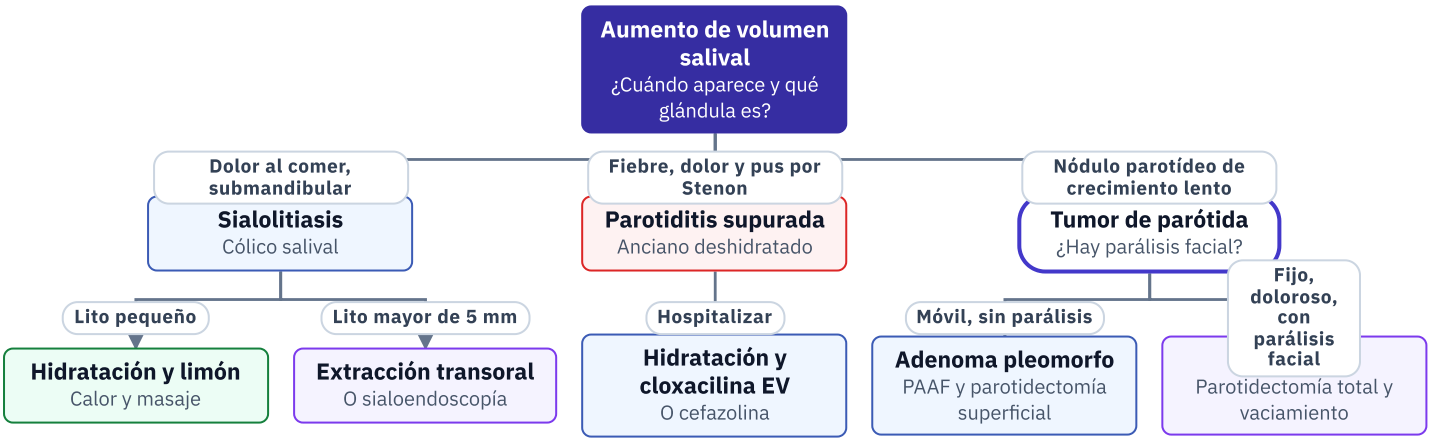


TABLA 14.19 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: SIALOLITIASIS VS PAROTIDITIS AGUDA VS ADENOMA PLEOMORFO

ENTIDAD SALIVAL	GLÁNDULA AFECTADA PRINCIPAL	PRESENTACIÓN CLÍNICA Y TEMPORALIDAD	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Sialolitiasis	Glándula Submandibular (85% en Wharton)	Cólico salival agudo desencadenado con las comidas	Hidratación + Sialogogos (limón) · Extracción quirúrgica
Parotiditis Supurada	Glándula Parótida (Conducto de Stenon)	Inflamación aguda, fiebre, salida de pus por papila de Stenon	Hospitalización + Cloxacilina / Cefazolina EV + Hidratación
Adenoma Pleomorfo	Glándula Parótida (Lóbulo superficial)	Nódulo parotídeo indoloro, móvil, crecimiento lento de años	PAAF + Parotidectomía superficial con preservación del VII par
Carcinoma Maligno	Submandibular / Menores (o Parótida)	Masa pétrea fija, dolorosa, PARÁLISIS FACIAL IPSILATERAL	Parotidectomía total + Resección de facial y vaciamiento cervical

REGLA DE ORO **Cólico al comer: submandibular** — Wharton; limón, hidratación, extracción

PRACTICA **Libro Gordo Otorrinolaringología**, preguntas **81–83** (pág. 23) · solucionario pág. 37.

Clase 14.19 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · CUERPOS EXTRAÑOS, GLÁNDULAS SALIVALES & ONCOLOGÍA CERVICAL

14.20 Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical

★★★ PRIORIDAD ALTA
13 preguntas reales 2013–2025

6.03.1.004 Cáncer de boca, labios y orofaringe — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Masa cervical · Cáncer laríngeo e hipofaríngeo · Masa cervical y tumores del cuello · Adenitis cervical · Cáncer nasosinusal · Odinofagias crónicas · Prevención de cáncer laríngeo

LO QUE TE PREGUNTAN

- El Carcinoma de Células Escamosas (espinocelular) representa > **90%** de los cánceres de cabeza y cuello.
- Toda masa cervical o adenopatía pétrea fija en un adulto > **40 años** fumador es CÁNCER hasta demostrar lo contrario.
- La otalgia refleja con otoscopía rigurosamente normal es una bandera roja mayor de tumor de faringe o laringe.
- Una disfonía persistente por más de **2 a 3 semanas** en un fumador exige laringoscopía para descartar cáncer de cuerda vocal.
- El método diagnóstico de elección para la masa cervical es la PAAF (Punción con Aguja Fina) guiada por ecografía.
- Está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO realizar una biopsia incisional abierta de una masa cervical sin estudio previo.



CARCINOMA DE LENGUA
Bates 12.ª ed., Fig. 7-71

ALGORITMO · ALGORITMO DE BANDERAS ROJAS Y MASA CERVICAL EN EL ADULTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

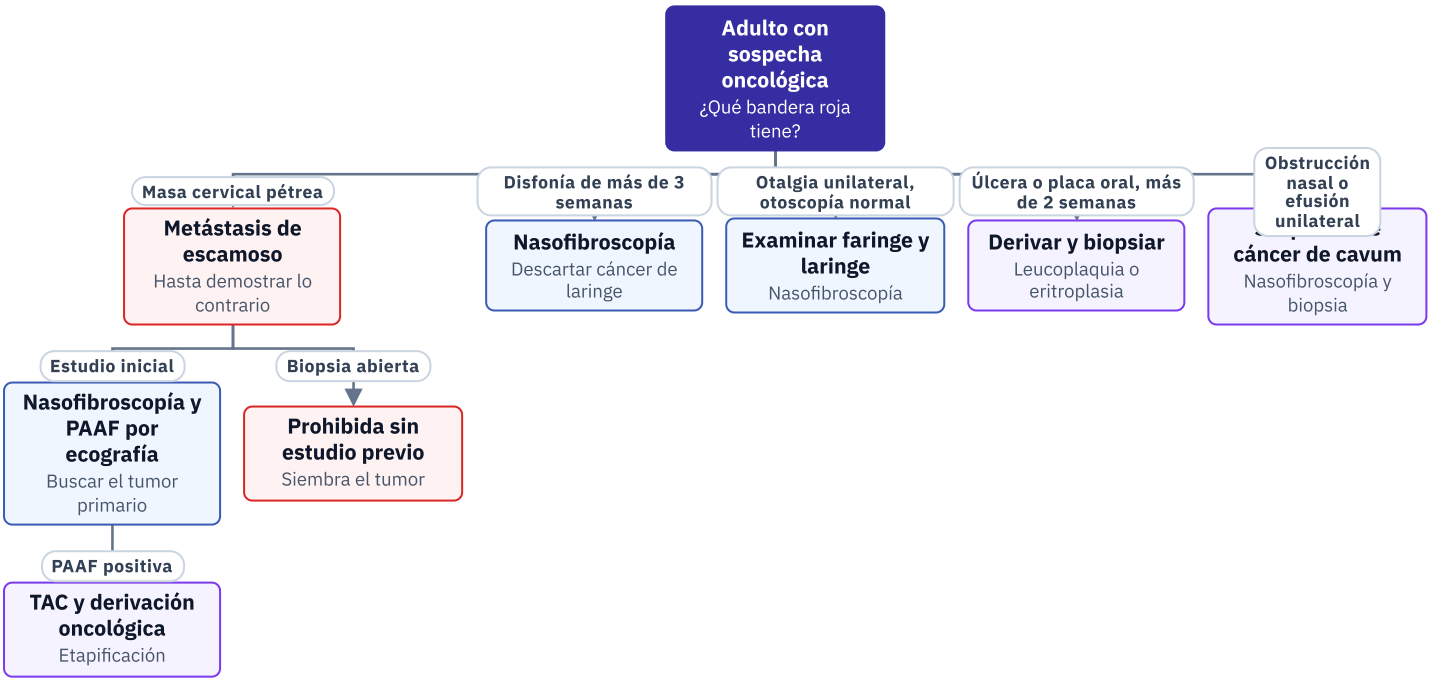


TABLA 14.20 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ETIOLÓGICO DE LA MASA CERVICAL SEGÚN GRUPO ETARIO

GRUPO ETARIO	ETIOLOGÍA MÁS FRECUENTE (80%)	EJEMPLOS TÍPICOS	CONDUCTA INICIAL
Niños (< 15 años)	Infecciosa / Inflamatoria	Adenitis reactiva bacteriana o viral, adenoflemón	Antibióticos orales · Ecografía si no cede
Adultos Jóvenes (16-40 años)	Congénita / Infecciosa / Linfoma	Quiste del conducto tirogloso, quiste branquial, mononucleosis	Ecografía de cuello + PAAF si sospecha de Linfoma
Adultos Mayores (> 40 años)	NEOPLÁSICA MALIGNA (80%)	Metástasis de Carcinoma Escamoso de orofaringe/laringe	PAAF bajo ecografía + Nasofibroscopía urgente (¡NO BIOPSIA ABIERTA!)

REGLA DE ORO **Escamoso en más del 90%** — Tabaco y alcohol; VPH-16 en orofaringe

PRACTICA **Libro Gordo Otorrinolaringología**, preguntas **2, 84–90** (págs. 10, 23–24) · solucionario págs. 25, 38.

Clase 14.20 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

Números que tienes que saber

Cortes, dosis, tiempos y metas de los 20 temas, tal como aparecen en el libro y en las clases. Las cifras van en negrita.

DATO	TIPO
BLOQUE 01 · PATOLOGÍA DEL OÍDO EXTERNO Y MEDIO	
14.1 Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos	pág. 3
10 días si < **2 años** o severa — Cuadros leves en mayores: **5 a 7 días**	CORTE
Amoxicilina **80 a 90 mg/kg**/día — Cada **12 horas**, **7 a 10 días**	DOSIS
Streptococcus pneumoniae — **35 a 40%** de los casos	CORTE
14.2 Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y Colesteatomatosa	pág. 4
Observar **12 semanas** — Del 80 al **90%** se resuelve solo	TIEMPO
Aseo y ciprofloxacino tópico **0,3%** — En la fase supurativa	CORTE
Otorrea indolora, **6 a 12 semanas** — Intermitente o persistente	TIEMPO
14.3 Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos	pág. 5
Drenaje en **24 a 48 horas** — Siempre antes de **7 días**	TIEMPO
Mínimo **6 a 8 semanas** — Seguimiento con cintigrafía o TAC	TIEMPO
Gotas de ciprofloxacino **0,3%** — Con o sin corticoide, **7 a 10 días**	TIEMPO
Oral solo con celulitis o inmunosupresión — Ciprofloxacino **500 mg** cada **12 horas**, **10 días**	DOSIS
14.4 Complicaciones de Otitis: Mastoiditis Aguda y Tromboflebitis	pág. 6
Ceftriaxona EV **100 mg/kg**/día — Primera línea	DOSIS
Sin respuesta en **24-48 h** — Al antibiótico endovenoso	TIEMPO
BLOQUE 02 · AUDIOLOGÍA & TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO	
14.6 Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia	pág. 8
Prednisona **1 mg/kg**/día — Máximo **60 mg** al día, **10 a 14 días**	DOSIS
GES para **65 años** o más — Hipoacusia bilateral	CORTE
Luego descenso progresivo — Reducir **10 a 20 mg** cada **3 a 5 días**	DOSIS
14.7 Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière	pág. 9
Sodio menor de **2 g**/día — Sin cafeína ni tabaco	DOSIS
Dimenhidrinato o lorazepam — Solo **48 horas**	TIEMPO
Prednisona **1 mg/kg**/día por **7 días** — Desde las primeras **72 horas**	DOSIS
Hidroclorotiazida o betahistina — **25 a 50 mg**; **16 a 24 mg** c/**12 h**	DOSIS
14.8 Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Síndrome de Ramsay Hunt	pág. 10
Bell: prednisona en **72 horas** — **1 mg/kg**/día, **7 a 10 días**	DOSIS
Más prednisona y analgesia — **1 mg/kg**/día por **10 a 14 días**	DOSIS
BLOQUE 03 · RINOLOGÍA & SENOS PARANASALES	
14.9 Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales	pág. 11
Oximetazolina más de **5 días** — Rinitis medicamentosa	META
Controla la obstrucción — Biodisponibilidad sistémica menor de **1%**	CORTE
Suspender antihistamínicos **5 a 7 días** antes — Los corticoides nasales no interfieren	TIEMPO
Ácaros: fundas y ropa de cama a más de 55 grados — Sin alfombras, cortinas gruesas ni peluches; humedad bajo **50 %**	CORTE
14.10 Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias	pág. 12
Persistencia: **10 días** o más — Sin ninguna mejoría	TIEMPO
Doble caída — Mejora a los **4 días** y recae con fiebre	TIEMPO
Inicio severo — Fiebre desde **39 °C** y pus por **3 a 4 días**	TIEMPO
Amoxicilina por **7 a 10 días** — Niños **80 a 90 mg/kg**/día; adultos **1 g** c/**12 h**	DOSIS

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
14.11 Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos	pág. 13
Mayor hipertenso, sangre en faringe — Foley con **8 a 10 mL** de agua más tapón	DOSIS
Retiro a las **48-72 horas** — Por otorrino; si falla, ligadura endoscópica	TIEMPO
BLOQUE 04 · FARINGE, LARINGE & VÍA AÉREA SUPERIOR	
14.13 Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina	pág. 15
Fiebre mayor de **38 °C** — Medida axilar	CORTE
No anafiláctica: cefadroxilo — **30 mg/kg**/día por **10 días**	DOSIS
Penicilina benzatina IM única — **1.200.000 UI** si pesa más de **27 kg**	DOSIS
Amoxicilina por **10 días** — **50 mg/kg**/día cada 12 o **24 horas**, máximo **1 g**	DOSIS
14.14 Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo	pág. 16
En frío: **4 a 6 semanas** — Si hay amigdalitis recurrentes	TIEMPO
Ensanchamiento mediastínico — Mediastinitis necrotizante, mortalidad sobre **40%**	CORTE
14.15 Hipertrofia Adenotonsilar y SAHOS Infantil: Indicaciones Quirúrgicas	pág. 17
Brodsky 4: amígdalas en beso — Ocupan más del **75%** de la vía aérea	CORTE
La hipertrofia adenotonsilar es la causa más común de SAHOS en niños entre 2 y **6 años**.	CORTE
14.16 Disfonía Crónica y Patología Benigna de Cuerdas Vocales: Nódulos, Pólipos y Edema de Reinke	pág. 18
Más de **2 a 3 semanas** — Se sospecha cáncer hasta demostrar lo contrario	TIEMPO
14.17 Croup / Laringitis Obstructiva vs Epiglotitis Aguda: Escala de Taussig y Manejo de Emergencia	pág. 19
0,15 a 0,6 mg/kg — Máximo **10 a 16 mg**; EV si no tolera	DOSIS
Corriente 1:1.000, **4 a 5 mL** — O racémica; con oxígeno	DOSIS
Adrenalina: observar **2 a 4 horas** — Por el efecto rebote	TIEMPO
BLOQUE 05 · CUERPOS EXTRAÑOS, GLÁNDULAS SALIVALES & ONCOLOGÍA CERVICAL	
14.18 Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea	pág. 20
Después se extrae — Lavado con agua a **37 °C** o pinza	CORTE
14.19 Patología de Glándulas Salivales: Sialolitiasis, Parotiditis y Adenoma Pleomorfo	pág. 21
80% en la parótida — De ellos, **80%** benignos	CORTE
Glándula más pequeña, más maligno — Parótida **20%**, submandibular **50%**, menores **80%**	CORTE
El **80-90%** de las sialolitiasis se localizan en la Glándula Submandibular a lo largo del conducto de Wharton.	CORTE
14.20 Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical	pág. 22
Tabaco y alcohol — Sinergia: riesgo hasta **30 veces** mayor	CORTE
Disfonía mayor de **3 semanas** — En fumador: cáncer de laringe	TIEMPO
Escamoso en más del **90%** — Tabaco y alcohol; VPH-16 en orofaringe	CORTE

Fármacos de primera línea

Esquemas de elección por enfermedad, tomados de las tarjetas de tratamiento de cada clase. Al final de la sección, las garantías GES.

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE	
14.1 Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos			pág. 3
Primera línea · Amoxicilina oral	**Amoxicilina 80 a 90 mg/kg/día**	Dividida cada **12 horas**; máximo **3 g** al día	
14.2 Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y Colesteatomatosa			pág. 4
La perforación central con otorrea · Tópico, no oral	**Aseo y ciprofloxacino tópico 0,3%**	En la fase supurativa	
14.3 Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos			pág. 5
Otitis externa difusa · Los tres pilares	**Gotas de ciprofloxacino 0,3%**	Con o sin corticoide, **7 a 10 días**	
Otitis externa difusa · Los tres pilares	**AINE o paracetamol**		
Hospitalizar	**Ciprofloxacino o ceftazidima endovenosos**	Dosis altas, por vía endovenosa	
14.4 Complicaciones de Otitis: Mastoiditis Aguda y Tromboflebitis			pág. 6
Toda mastoiditis se hospitaliza · Manejo médico	**Ceftriaxona EV 100 mg/kg/día**	Primera línea	
Toda mastoiditis se hospitaliza · Manejo médico	**Asociar clindamicina o vancomicina**	Vancomicina si hay neumococo o SAMR resistente	
14.6 Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia			pág. 8
Corticoides precoces, en dosis altas · Ataque inicial	**Prednisona 1 mg/kg/día**	Máximo **60 mg** al día, **10 a 14 días**	
Corticoides precoces, en dosis altas · Rescate	**Corticoide intratimpánico**	Dexametasona o metilprednisolona	
14.7 Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière			pág. 9
Vértigo de días, sin hipoacusia · Sedantes máximo 48 horas	**Prednisona 1 mg/kg/día por 7 días**	Desde las primeras **72 horas**	
14.8 Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Síndrome de Ramsay Hunt			pág. 10
La causa más común · Primeras 72 horas	**Antivirales solos no sirven**	Solo se suman en casos graves	
Pronóstico y tratamiento	**Valaciclovir 1 g cada 8 horas**	**7 a 10 días**; o aciclovir **800 mg** x5	
Pronóstico y tratamiento	**Más prednisona y analgesia**	**1 mg/kg**/día por **10 a 14 días**	
Herpes zóster · Antiviral y analgesia	**Aciclovir o valaciclovir por 7 días**	Ojalá en las primeras **72 horas**	
14.9 Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales			pág. 11
Corticoide intranasal primero · Primera línea	**Corticoide intranasal**	Fluticasona o mometasona, 1 vez al día	
14.10 Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias			pág. 12
Amoxicilina primero · Solo si es bacteriana	**Amoxicilina por 7 a 10 días**	Niños **80 a 90 mg/kg**/día; adultos **1 g** c/**12 h**	
Amoxicilina primero · Solo si es bacteriana	**Antibiótico reciente, enfermedad crónica o falla**		
Doce semanas o más · Médico y derivación	**Lavados salinos y corticoide nasal diario**	Control del alérgeno; antibiótico solo en exacerbación bacteriana	
Infecciones de la vía aérea superior	**Autolimitadas de 7 a 10 días: sin antibióticos**		
14.13 Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina			pág. 15
Penicilina · Primera línea	**Penicilina benzatina IM única**	**1.200.000 UI** si pesa más de **27 kg**	
Penicilina · Primera línea	**Amoxicilina por 10 días**	**50 mg/kg**/día cada 12 o **24 horas**, máximo **1 g**	
La secuela · Tratamiento y prevención	**Reposo, penicilina, AAS y corticoides**	AAS en artritis; corticoides en carditis moderada a grave	

Fármacos de primera línea · continuación

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE
14.14 Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo		pág. 16
Absceso periamigdalino · Drenaje y antibiótico	**Antibiótico endovenoso**	Cubre estreptococo y anaerobios
Absceso periamigdalino · Drenaje y antibiótico	**Dexametasona y analgesia**	Una dosis EV reduce edema y trismus
14.16 Disfonía Crónica y Patología Benigna de Cuerdas Vocales: Nódulos, Pólipos y Edema de Reinke		pág. 18
Disfonía aguda · Laringitis viral o fonotrauma	**Reposo vocal relativo, hidratación, sin tabaco, sin antibióticos**	
14.19 Patología de Glándulas Salivales: Sialolitiasis, Parotiditis y Adenoma Pleomorfo		pág. 21
Parotiditis bacteriana en el anciano · Hospitalizar	**Hidratación EV y cloxacilina**	O cefazolina; vancomicina si SAMR

GES de Otorrinolaringología

Garantías Explícitas en Salud que aparecen en los temas de esta especialidad: el EUNACOM pregunta la edad, el examen y el plazo que garantizan.

GES **Garantía GES Hipoacusia Neurosensorial Bilateral en el prematuro y del adulto de 65 años y más**

Tema **14.2** · Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y Colesteatomatosa
6.03.1.021 · 6.03.1.022 · 6.03.4.005
pág. 4

GES **Garantía GES Hipoacusia Moderada, Severa y Profunda en menores de 4 años · GES Hipoacusia en mayores de 65 años**

Tema **14.5** · Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber)
6.03.4.006 · 6.03.4.008 · 6.03.1.007
pág. 7

GES **Garantía GES Hipoacusia bilateral en personas de 65 años y más (audífonos)**

Tema **14.6** · Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia
6.03.2.018 · 6.03.1.008 · 6.03.2.006
pág. 8

GES **Garantía GES Colecistectomía / Alivio del dolor por cáncer avanzado y cuidados paliativos**

Tema **14.20** · Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical
6.03.1.004 · 6.03.1.015 · 6.03.1.005
pág. 22

Sin garantía GES específica (16 temas): 14.1 · 14.3 · 14.4 · 14.7 · 14.8 · 14.9 · 14.10 · 14.11 · 14.12 · 14.13 · 14.14 · 14.15 · 14.16 · 14.17 · 14.18 · 14.19. Revisa igual la norma MINSAL que cita cada página.

Plan de repaso de 7 días

Los temas van de mayor a menor prioridad (★ según preguntas reales EUNACOM 2013–2025). Cada día: lee la página del tema, recorre su algoritmo y haz sus preguntas del Libro Gordo; corrige con el solucionario.

DÍA 1

4 temas · ★★★

- ★★★ **14.13** Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina 15
- ★★★ **14.10** Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias 12
- ★★★ **14.20** Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical 22
- ★★★ **14.3** Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos 5

Practica: Libro Gordo Otorrinolaringología, preguntas 2, 16–18, 20–21, 38, 40–41, 58–63, 73, 84–90.

DÍA 2

4 temas · ★★★

- ★★★ **14.7** Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière 9
- ★★★ **14.2** Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y Colesteatomatosa 4
- ★★★ **14.4** Complicaciones de Otitis: Mastoiditis Aguda y Tromboflebitis 6
- ★★★ **14.9** Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales 11

Practica: Libro Gordo Otorrinolaringología, preguntas 1, 13–15, 33–36, 52–54.

DÍA 3

3 temas · ★★★

- ★★★ **14.12** Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal 14
- ★★☆ **14.6** Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia 8
- ★★☆ **14.17** Croup / Laringitis Obstructiva vs Epiglotitis Aguda: Escala de Taussig y Manejo de Emergencia 19

Practica: Libro Gordo Otorrinolaringología, preguntas 3, 26–32, 49–51, 55–57.

DÍA 4

3 temas · ★★

- ★★☆ **14.14** Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo 16
- ★★☆ **14.1** Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos 3
- ★★☆ **14.5** Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber) 7

Practica: Libro Gordo Otorrinolaringología, preguntas 4–12, 22–25, 64–70.

DÍA 5

3 temas · ★★

- ★★☆ **14.16** Disfonía Crónica y Patología Benigna de Cuerdas Vocales: Nódulos, Pólipos y Edema de Reinke 18
- ★★☆ **14.19** Patología de Glándulas Salivales: Sialolitiasis, Parotiditis y Adenoma Pleomorfo 21
- ★☆☆ **14.15** Hipertrofia Adenotonsilar y SAHOS Infantil: Indicaciones Quirúrgicas 17

Practica: Libro Gordo Otorrinolaringología, preguntas 19, 37, 71–72, 81–83.

DÍA 6

3 temas · ★

- ★☆☆ **14.8** Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Síndrome de Ramsay Hunt 10
- ★☆☆ **14.18** Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea 20
- ★☆☆ **14.11** Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos 13

Practica: Libro Gordo Otorrinolaringología, preguntas 42–48, 75–80.

DÍA 7

- Relee «**Números que tienes que saber**» y «**Fármacos de primera línea**» pág. 23
- Repasa solo las **Trampas EUNACOM** y la **Regla de oro** de los temas ★★★: 14.2 · 14.3 · 14.4 · 14.7 · 14.9 · 14.10 · 14.12 · 14.13 · 14.20
- Simulacro: las **90 preguntas** del Libro Gordo Otorrinolaringología en 120 minutos; vuelve a la página de cada tema que falles.

Índice por prioridad ★

El número a la izquierda es la cantidad de preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) en los códigos Perfil V3 del tema.

★★★ Prioridad alta · 9 temas

21 14.13. Faringoamigdalitis Aguda Bacteriana: Criterios de Centor/McIsaac y Penicilina 15
13 14.10. Rinosinusitis Aguda Viral vs Bacteriana: Criterios y Complicaciones Orbitarias 12
13 14.20. Cáncer de Cabeza y Cuello: Carcinoma Escamoso, Banderas Rojas y Masa Cervical GES 22
10 14.3. Otitis Externa Difusa vs Otitis Externa Maligna en Diabéticos 5
7 14.7. Síndrome Vertiginoso Periférico: VPPB, Neuronitis Vestibular y Enfermedad de Ménière 9
6 14.2. Otitis Media con Efusión (OME), OMC Simple y Colesteatomatosa GES 4
6 14.4. Complicaciones de Otitis: Mastoiditis Aguda y Tromboflebitis 6
6 14.9. Rinitis Alérgica vs No Alérgica: Clasificación ARIA y Corticoides Intranasales 11
6 14.12. Poliposis Nasal, Desviación Septal y Fractura Nasal 14

★★ Prioridad media · 7 temas

5 14.6. Hipoacusia Sensorioneural Súbita, Trauma Acústico y Presbiacusia GES 8
5 14.17. Croup / Laringitis Obstructiva vs Epiglotitis Aguda: Escala de Taussig y Manejo de Emergencia 19
4 14.14. Complicaciones Supurativas: Absceso Periamigdalino, Parafaríngeo y Retrofaríngeo 16
3 14.1. Otitis Media Aguda (OMA): Diagnóstico Otoscópico, Etiología y Criterios Antimicrobianos 3
3 14.5. Evaluación Auditiva: Audiometría, Impedanciometría y Diapasones (Rinne y Weber) GES 7
3 14.16. Disfonía Crónica y Patología Benigna de Cuerdas Vocales: Nódulos, Pólipos y Edema de Reinke 18
3 14.19. Patología de Glándulas Salivales: Sialolitiasis, Parotiditis y Adenoma Pleomorfo 21

★ Prioridad baja · 4 temas

2 14.15. Hipertrofia Adenotonsilar y SAHOS Infantil: Indicaciones Quirúrgicas 17
1 14.8. Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Síndrome de Ramsay Hunt 10
1 14.18. Cuerpos Extraños en ORL: Pila de Botón como Emergencia Quirúrgica vs Vía Aérea 20
0 14.11. Epistaxis Anterior vs Posterior: Cauterización y Taponamientos 13